

**Handreichung**

**zur Umsetzung des Lehrplans**

**für den Ausbildungsberuf**

**Staatlich anerkannte Heilpädagogin/  
Staatlich anerkannter Heilpädagoge**

**2015**

# Inhaltsverzeichnis

|   |                                                                                                                                  |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Vorbemerkungen                                                                                                                   | 3  |
| 2 | Mitglieder der Implementierungsgruppe                                                                                            | 4  |
| 3 | Didaktisch-methodische Handreichungen                                                                                            | 5  |
|   | Modul 1: „Heilpädagogisches Handeln als wissenschaftlich begründete und ethisch reflektierte Tätigkeit“                          | 5  |
|   | Heilpädagogisches Handeln unter gesellschaftlichen, institutionellen und rechtlichen Aspekten                                    | 5  |
|   | Hinführung zur Arbeit mit Fachtexten im Ausbildungsgang „Staatlich anerkannter Heilpädagoge/staatlich anerkannte Heilpädagogin“  | 8  |
|   | Inklusion als Vision und Prozess                                                                                                 | 9  |
|   | Heilpädagogisches Handeln unter berufsethischem Aspekt                                                                           | 10 |
|   | Kompetenzorientierte Leistungsbewertung im Ausbildungsgang Staatlich anerkannter Heilpädagoge/staatlich anerkannte Heilpädagogin | 11 |
|   | Bundesteilhabegesetz                                                                                                             | 12 |
|   | Modul 2: „Medizinische Grundlagen“                                                                                               | 13 |
|   | Modul 3: „Psychologisch-psychiatrische und soziologische Grundlagen heilpädagogischen Handelns“                                  |    |
|   | <b>Teil 1:</b> Psychologische Grundlagen heilpädagogischen Handelns                                                              | 14 |
|   | <b>Teil 2:</b> Soziologische Grundlagen heilpädagogischen Handelns                                                               | 16 |
|   | <b>Teil 3:</b> Psychologisch-psychiatrische Grundlagen heilpädagogischen Handelns                                                | 19 |
|   | Modul 4: „Grundlagen der Diagnostik und Förderung von Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten“                                   |    |
|   | <b>Teil 1:</b> Grundlagen der Diagnostik und Förderung von Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten                               | 22 |
|   | <b>Teil 2:</b> Grundlagen der Diagnostik und Förderung von Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten                               | 32 |
|   | Modul 5: „Sozial- und Qualitätsmanagement“                                                                                       | 36 |
|   | „Sozial- und Qualitätsmanagement in der Heilpädagogik“                                                                           | 37 |
|   | Modul 13: „Heilpädagogisches Spielbegleitung“                                                                                    | 38 |
|   | „Heilpädagogisches Spielbegleitung“ Teil II                                                                                      | 40 |
|   | Modul 15: „Motorische Entwicklungsförderung (MEF)“                                                                               | 41 |
|   | Modul 17: „Heilpädagogisches Handeln in den Arbeitsfeldern“                                                                      |    |
|   | Heilpädagogen in Diensten und Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung                                                             | 43 |
|   | Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und drohenden Behinderungen      | 44 |
|   | Modul 18: „Heilpädagogische Förderpraxis – Berufspraktikum – Anfertigen einer Facharbeit“                                        | 45 |
|   | „Heilpädagogische Förderpraxis – Berufspraktikum“                                                                                | 46 |

# 1 Vorwort

„HEILPÄDAGOGIK –  
das ist die Lust am Unfertigen, Ungewissen, am Ungeahnten.  
Im Moment des Nicht-mehr-weiter-Wissens innehalten,  
Staunen über das Unfassbare,  
um sich dann Zeit zu lassen für Schöpferisches  
und vielleicht einen Werte-Wandel.  
Das Tempo, mit dem oft Veränderung erzwungen werden will,  
ist meist nicht einzuhalten.  
Symptome oder Probleme sollen schnellstens verschwinden.  
Erkennen und Handeln haben aber eine eigene Dynamik.  
In unserem Zeitalter der Geschwindigkeiten geraten unsere Bemühungen, die eben Zeit  
brauchen, zum Kontrast.  
Erfolgsdruck ist häufig gepaart mit Zeitdruck.  
Stressoren dieser Art sind in der Heilpädagogik fehl am Platz.“

*Dr. Dieter Lotz*

Diese Worte charakterisieren nicht nur das Wesen heilpädagogischer Arbeit, sondern sind auch in einem besonderen Maße handlungsleitend für die Ausbildung von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Geht es hier doch um eine Aufstiegsfortbildung von Personen, die in der Regel über einen sozialpädagogischen bzw. sozialpflegerischen Fachschulabschluss verfügen und in einem entsprechenden Arbeitsfeld tätig sind.

Dabei ist von einer mindestens einjährigen, nicht selten aber auch jahrzehntelangen Berufstätigkeit auszugehen. Dieser großen Spannbreite beruflicher Vorerfahrungen gilt es in der Ausbildung gerecht zu werden.

Durch den Charakter der berufsbegleitenden Form ergeben sich in allen Ausbildungsgruppen neue Konstellationen der vertretenen Arbeitsfelder und daraus folgend durchaus differenzierte Erwartungen der Fachschüler an die Ausbildung.

Dieser komplexen Bedürfnislage müssen die Lehrenden entsprechen und sich immer wieder neu und flexibel auf die Dynamik der Anforderungen in der Praxis einstellen.

Aus diesem Grund werden von der Implementierungsgruppe methodische Handreichungen zu drei Modulen des am 1. August 2015 in Kraft getretenen Lehrplanes erarbeitet und im nachfolgenden Papier veröffentlicht.

Diese Handreichung bezieht sich auf ausgewählte Aspekte der Kernmodule 1, 2, 3 und 4.

Dabei orientieren sich die methodischen Anregungen an den zu erwerbenden Kompetenzen der Fachschüler.

Sie sind als Vorschläge, die sich aus Erfahrungen speisen, aufzufassen.

Ausdrücklich stehen die Ressourcen der erwachsenen Fachschüler, die sich im Rahmen ihres persönlichen beruflichen Werdegangs weiterentwickeln wollen, im Focus der Betrachtung.

Stoff-Zeit-Pläne sind nicht Gegenstand dieser Handreichung. Sie sind individuell an den Schulen zu erarbeiten und werden nicht vorgegeben. Somit wird hier Raum für individuelle Schwerpunktsetzungen gelassen und Variationen werden ermöglicht.

Die Mitglieder der Implementierungsgruppe sind an Initiativen zur Ausgestaltung des kollegialen Erfahrungsaustausches sehr interessiert und laden ausdrücklich dazu ein.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Klenner, Wolfgang, Heilpädagogik als Handlungswissenschaft – dargestellt am Beispiel der Heilpädagogischen Übungsbehandlung, Hrsg. Berufsverband der Heilpädagogen (BHP) e. V., Berlin 2006

## **2 Mitglieder der Implementierungsgruppe**

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Engert, Ulrike        | Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises<br>„Johann August Röbling“, Mühlhausen |
| Hockauf, Christine    | Staatliches Berufsbildungszentrum Weimar                                              |
| Lenk, Sybille         | Staatliches Berufsbildungszentrum Weimar                                              |
| Meisel-Becker, Renate | Staatliches Berufsbildungszentrum Weimar                                              |
| Schmalisch, Antje     | Staatliches Berufsbildungszentrum Weimar                                              |

## **Berater und Unterstützer der Implementierungsgruppe**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Birkefeld, Anja | Staatliches Berufsbildungszentrum Weimar |
| Tusch, Petra    | Staatliches Berufsbildungszentrum Weimar |

### **3 Didaktisch- methodische Handreichungen zu den Modulen**

#### **Modul 1: „Heilpädagogisches Handeln als wissenschaftlich begründete und ethisch reflektierte Tätigkeit“**

##### **Inhalte: Heilpädagogisches Handeln unter gesellschaftlichen, institutionellen und rechtlichen Aspekten**

Ausgangspunkt ist das Berufsbild Heilpädagoge/Heilpädagogin (Hrsg. Berufsverband der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Fachverband für Heilpädagogik BHP e. V.). In diesem sind lebenslaufbezogene und lebensortbezogene Tätigkeitsfelder aufgeführt. Hierzu erarbeiten sich die Fachschüler einen Überblick, der es ihnen ermöglicht, sowohl eigenes Handeln im aktuellen Tätigkeitsfeld gründlich zu reflektieren als auch konkrete Vorstellungen von den anderen wichtigsten Arbeitsfeldern zu entwickeln, um so ggf. auch das Arbeitsfeld gut wechseln zu können.

In Vorbereitung auf die Behandlung und als erster Teil des Themenkomplexes wird von allen Teilnehmern ein Beleg erarbeitet, der sich auf das gegenwärtige Arbeitsfeld bezieht. Auf dem Deckblatt erscheint neben den üblichen Angaben bereits die konkrete Benennung des Arbeitsfeldes:

z. B.: *Heilpädagogische Einrichtungen und Dienste – Arbeitsfeld Hilfen zur Erziehung in einer vollstationären Wohnform entsprechend § 35a KJHG*

Der Beleg könnte beispielsweise nach folgender Gliederung verfasst sein:

- 1 Vorbemerkungen über die Art der Einrichtung und deren Auftrag
- 2 Rechtliche Rahmenbedingungen der Tätigkeit
- 3 Leitbild des Trägers und Einblick in das Konzept
- 4 Personelle und materiell – technische Ausstattung
- 5 Finanzierung
- 6 Verortung der Einrichtung im Sozialraum
- 7 Interdisziplinarität
- 8 Teamarbeit
- 9 Zusammenarbeit mit Personensorgeberechtigten, Angehörigen und gesetzlichen Betreuern
- 10 Öffentlichkeitsarbeit
- 11 Art der Stelle und Auftrag gemäß der Stellenbeschreibung
- 12 Persönliche Reflektion des eigenen Arbeitsfeldes
- 13 Quellen
- 14 Eidesstattliche Erklärung
- 15 Anhang

Dem Anhang können unterschiedliche Materialien z. B. Flyer des Trägers, Kindergartenzeitschriften, methodisches Material, Fotos der Einrichtung o. ä. beigelegt werden.

Für die Erarbeitung des Belegs ist den Fachschülern ein Zeitraum von mindestens vier Wochen zur Verfügung zu stellen.

Besonderes Augenmerk sollte hier auf Punkt 12 der Gliederung gerichtet werden.

Hier ist es wichtig, den Fachschülern unbedingte Vertraulichkeit zuzusichern, d. h. der Beleg wird dem Fachlehrer persönlich übergeben und der Fachschüler erhält den Beleg aus den Händen des Fachlehrers persönlich zurück.

Das ist deswegen so wichtig, damit der Fachschüler in seiner Reflektion der eigenen Rolle und Tätigkeit tatsächlich eine Stufe der Selbstöffnung erreichen kann, die es ihm ermöglicht, zu Einsichten zu gelangen, die persönliche Entwicklung initiieren oder vertiefen.

Hierbei ergibt sich eine starke Verknüpfung mit dem Thema: Heilpädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Beziehung, welches im Vorfeld behandelt wurde. Speziell die Punkte des Selbstverständnisses, der Selbstwahrnehmung und der Achtsamkeit werden hier beleuchtet.

Gleichzeitig haben die Fachschüler die Möglichkeit mit Hilfe einer einfühlsamen, kompetenten jedoch nicht unmittelbar beteiligte Person – der des Fachlehrers – sich in Bezug auf eigene Grenzen, das Verhältnis von Nähe und Distanz bzw. eventuelle Überidentifikation zu reflektieren.

Erfahrungsgemäß wird diese Möglichkeit intensiv genutzt.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine kompetente, ausführliche schriftliche Rückmeldung an den Fachschüler.

Gegebenenfalls sollte diese auch Gesprächsangebote enthalten. Um eine ehrliche, gründliche Reflektion des Fachschülers zu erreichen, sollte vorher ein Vertrauensverhältnis aufgebaut worden sein. Daraus ergibt sich, dass dieser Beleg frühestens nach einem halben Jahr Unterricht in Auftrag gegeben wird.

Der Beleg gilt als Leistungsnachweis. Punkt 12 wird nicht einbezogen.

Weiteres Vorgehen:

Nachdem alle Fachschüler wieder im Besitz ihrer Belege sind, finden sie sich in Gruppen entsprechend ihrer Arbeitsfelder zusammen und bereiten sich gemeinsam auf die Vorstellung ihres Tätigkeitsfeldes vor (z. B. Kindertagesstätte, Frühförderstelle, Wohnheim nach SGB IV, Hilfen zur Erziehung usw.).

Jede Gruppe erhält in einer Doppelstunde die Gelegenheit, ihr Arbeitsfeld mit seinen Besonderheiten vorzustellen und Fragen dazu zu beantworten. Außerdem wird jeweils eine Handreichung erarbeitet, so dass alle Fachschüler einen Überblick über die spezifischen Aufgaben des Heilpädagogen im jeweiligen Arbeitsfeld haben.

Die Handreichungen sollten eine jeweils ähnliche Struktur aufweisen.

Fragestellungen können hier bearbeitet werden:

- 1 Worin besteht der Arbeitsauftrag der Einrichtung?
- 2 Welcher Personenkreis wird gebildet, erzogen, betreut oder begleitet?
- 3 Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sind handlungsleitend?
- 4 Welcher Weg führt die Klienten in die Einrichtung?
- 5 Welche unterschiedlichen Konzepte bestehen?
- 6 Welchen Auftrag haben Heilpädagogen in diesem Arbeitsfeld?
- 7 Mit welchen Partnern arbeiten Heilpädagogen in diesem Arbeitsfeld zusammen?
- 8 Welche speziellen Erfahrungen aus diesem Arbeitsfeld sollen weitergegeben werden?

In der Planung der einzelnen Stunden hat es sich als günstig erwiesen, einer lebenslaufbezogenen Systematik zu folgen. Manchmal ist auch nur ein Vertreter eines wichtigen Arbeitsfeldes in der Klasse, so dass dieser auch gegebenenfalls mehr Unterstützung des Fachlehrers benötigt. Unter Umständen muss ein Fachlehrer auch ein relevantes Arbeitsfeld selbst vorstellen, wenn in der Klasse niemand ist, der dieses Arbeitsfeld vertritt.

Der Einsatz unterschiedlichster Materialien lockert die Unterrichtseinheiten auf. Zu diesen Materialien gehören in jedem Fall die Belege zu den Arbeitsfeldern (Punkt 12 wird von den Fachschülern vorher ausgeheftet) Alle anderen sensiblen Daten (wenn z. B. Fachschüler konkrete Aussagen über Pflegesätze in Wohneinrichtungen gemacht haben) werden ebenfalls entfernt oder geschwärzt. Darauf sollte der Fachlehrer im Vorfeld des Unterrichtsabschnittes jeweils noch einmal ausdrücklich hinweisen und dies als Belehrung aktenkundig machen.

Das Einbeziehen der Belege in den weiteren Unterricht hat für die Fachschüler auch noch den Effekt, dass sie erleben, wie ihre Vorarbeit von den anderen Teilnehmern wertschätzend wahrgenommen wird und für den Fachlehrer einen wichtigen Teil seiner Unterrichtsgestaltung darstellt.

## Didaktisch-methodische Handreichungen zu den Modulen

Neben den Belegen können natürlich auch viele andere Materialien wie kleine Filme, Fotos, Heimzeitungen oder Informationsblätter unterschiedlicher Träger in die Arbeit einbezogen werden.

In der Regel ergeben sich in den Unterrichtseinheiten sehr interessante Diskussionen zur Stellung und dem Selbstverständnis des Heilpädagogen in seinem Arbeitsfeld.

In diesem Zusammenhang kann auf die vertiefende Betrachtung des Themas in den Wahlpflichtkursen verwiesen werden.

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit kann der Verweis auf Organisationen und Verbände, die Heilpädagogen berufspolitisch vertreten, erfolgen.

Hierbei kann auch auf Materialien des Berufsverbandes der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen – Fachverband für Heilpädagogik (BHP) e. V., Bundesgeschäftsstelle Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin (030 – 40-605060) [info@bhponline.de](mailto:info@bhponline.de) verwiesen werden.

Diese Materialien können, ohne dass den Schulen Kosten entstehen, angefordert werden.

Über den Verband sind auch aktuelle Positionspapiere zu heilpädagogischem Handeln in den einzelnen Arbeitsfeldern zu beziehen.

### Modul 1

---

Interaktionsmodell der Entstehung von Behinderungszuständen auf ein Beispiel aus der eigenen Praxis beziehen

Belegarbeit „Heilpädagogische Einrichtungen und Dienste“

Vorstellung des eigenen Arbeitsbereiches und Reflexion der eigenen heilpädagogischen Tätigkeit (Darstellung in einer Gruppenpräsentation entsprechend der Arbeitsfelder)

Fallbearbeitung: Hilfeplanung als Leistungskontrolle unter Zuhilfenahme aller Aufzeichnungen (im Zusammenhang mit den Themen Inklusion und Persönliches Budget unter dem Gesichtspunkt des Paradigmenwechsels)

Klassenarbeit zur heilpädagogischen Beziehungsarbeit (Transfer auf ein Praxisbeispiel gelungener oder misslungener Beziehungsgestaltung)

Zusammenfassende Darstellung eines wissenschaftlichen Fachtextes zu einem prüfungsrelevanten Thema in Form eines Kurzvortrages

## **Hinführung zur Arbeit mit Fachtexten im Ausbildungsgang „ Staatlich anerkannter Heilpädagoge/staatlich anerkannte Heilpädagogin“**

Entsprechend den Anforderungen des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR) Niveaustufe 6 sollen Fachschülerinnen und Fachschüler an den Umgang mit wissenschaftlichen Texten herangeführt werden.

Diese Kompetenzen sind Voraussetzungen dafür, die Studierfähigkeit zu erlangen.

Dabei gilt es, zunächst unterschiedliche Möglichkeiten des Lesens (zum Beispiel kursorisch), des Konspektierens sowie Exzerpierens zu wiederholen.

Die Motivation ergibt sich daraus, dass von den Fachschülern erwartet wird, dass sie bei der Anfertigung von Belegen und der Facharbeit wissenschaftliche Arbeitsmethoden anwenden können.

Eine Möglichkeit, dies im Laufe der Ausbildung vorzubereiten und zu üben, ist die kontinuierliche Arbeit mit Texten aus Fachzeitschriften.

Die Auswahl wird vom Lehrer/der Lehrerin getroffen. Inhaltlich orientiert er/sie sich an prüfungsrelevanten Themen.

Die Textarbeit dient der Systematisierung, der Vertiefung oder Weiterführung der Thematik.

Die Fachschüler wählen selbst den für sie interessantesten Text in dem gegebenen Rahmen. Dies bedeutet, dass der Lehrer/die Lehrerin eine hinreichende Zahl von Texten vorbereiten muss.

Die Texte sollen vier bis sechs Seiten umfassen und müssen von den Fachschülern auf einer Seite schriftlich zusammengefasst werden.

Aus dieser Zusammenfassung wird ein Handout erarbeitet. Die Form der Darstellung, welche in jedem Fall eine exakte Quellenangabe enthalten muss, wird vom Lehrer vorgegeben.

Die Darstellung erfolgt analog der Vorgaben in der Facharbeit im Fließtext.

Die Handouts werden in einem ca.15 minütigen Vortrag vor der Klasse vorgestellt, wobei auch hier möglichst frei gesprochen werden sollte. Die Fachschüler haben die Gelegenheit mitzuteilen, wie sie sich dem Text genähert haben oder welche Quellen sie benutzt haben, um Fachbegriffe zu klären usw.

Am Ende des Vortrages erhält jeder Fachschüler der Klasse ein Exemplar des Handouts und kann dieses seinen Unterlagen zum jeweiligen Themengebiet zuordnen.

Dies stellt eine effektive Form der Prüfungsvorbereitung dar, die von den Schülern in der Regel sehr ernst genommen wird.

Welche Fragen liegen den Kriterien zur Bewertung zu Grunde?

Ist der wesentliche Inhalt des Fachtextes erfasst worden?

Ist der Fachschüler in der Lage, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden?

Hat der Fachschüler die verwendeten Fachbegriffe verstanden und kann mit diesen angemessen umgehen?

Wurden die Formvorschriften (Quellenangabe, Beschränkung auf eine Seite) beachtet?

Als Kriterien der Bewertung folgen aus diesen Fragen:

1. Der wesentliche Inhalt des Fachtextes ist erfasst worden
2. In der Zusammenfassung wurde Wesentliches von Unwesentlichem unterschieden
3. Fachtermini wurden verstanden und angemessen verwendet
4. Formvorschriften wurden beachtet (Indikatoren: Quellenangabe exakt, Seitenzahl eingehalten)

Als Bewertungsraster ist eine Stufung in trifft voll zu, trifft im Wesentlichen zu usw.

praktikabel. Es wäre aber auch ein Punktsystem denkbar. Dieses sollte den Fachschülern rechtzeitig mitgeteilt werden.

Sybille Lenk



## **Zum Thema „Inklusion als Vision und Prozess“**

Mit der Verabschiedung der UN – Behindertenrechtskonvention im März 2009 ist auch in Deutschland ein Meilenstein in der Politik gesetzt worden. Der Paradigmenwechsel von der fürsorglichen Gewährung von Unterstützungsleistungen an einzelne Individuen zur Absicherung der Rechte von Menschen mit Behinderungen auf Unterstützung in verschiedenen Lebensaltersstufen, Lebenslagen und gesellschaftlichen Institutionen ist klar zu verdeutlichen. Dies kann man im Unterricht gut anhand von historischen Entwicklungen tun.

Bei der Gestaltung des Unterrichtes ist es günstig, wenn man auf Filmsequenzen, Abbildungen von Anstaltsbauten oder das Lesen von Anstaltsordnungen zurückgreift.

Dabei bildet sich die Erkenntnis heraus, in wie vielen Fällen paternalistisches Handeln von Mitarbeitern Selbstständigkeit und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen auch heute noch oft unterbindet. Die Rolle des Heilpädagogen als Begleiter und Unterstützer von Verselbstständigungsprozessen wird in der Regel lebhaft reflektiert und trägt somit auch dazu bei, die Erkenntnis über Komplexität und Dynamik der Berufsausübung zu vertiefen.

Herausragende Bedeutung hat die Behindertenrechtskonvention dadurch, dass sie sich auf alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens bezieht – also Erziehung, Bildung, Arbeit, Wohnen, Freizeit – und damit alle gesellschaftlichen Institutionen betroffen sind.

Das bedeutet, dass erst das Vorhandensein inklusiver gesellschaftlicher Strukturen es erlaubt, von Inklusion zu reden.

Insofern ist die Umsetzung der UN – Behindertenrechtskonvention als strukturelle Beseitigung institutioneller, bildungspolitischer, baulicher, sozialer und wirtschaftlicher Behinderungen mit dem Ziel der umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe bisher strukturell behinderter, benachteiligter und ausgegrenzter Menschen zu verstehen.

Zur Verdeutlichung dieser These empfiehlt es sich, aktuelle Materialien von den Fachschülern in den Unterricht einbringen zu lassen bzw. selbst einzubringen (Zeitungsartikel, eigene Beobachtungen über Veränderungsprozesse, Auszüge aus Konzepten, Erfahrungsberichte Betroffener usw.)

Pressemitteilungen der Bundesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen erscheinen wöchentlich und sind wegen ihrer Aktualität gut nutzbar.

Aber auch die regelmäßig in leichter Sprache erscheinenden Themenhefte der Aktion Mensch, herausgegeben in Kooperation mit den Verbänden der Behindertenhilfe und -selbsthilfe, bieten sehr gute Anregungen für die Unterrichtsgestaltung.

Nicht zuletzt bieten aktuelle Studien der auch mit schulischer und außerschulischer Inklusion befassten Landesministerien eindrucksvolles Material zur intensiven Auseinandersetzung im Unterrichtsgeschehen.

Die von der Behindertenrechtskonvention geforderte Einbeziehung behinderter Menschen kann nur vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Ausgrenzungsprozesse in ihrer Bedeutung erfasst werden. Die Schwierigkeiten und Widerstände in der Umsetzung in der Forderungen der Konvention zeigen deutlich, dass diese nur im systemischen Kontext mit gesellschaftlichen Exklusionsprozessen verstehbar wird.

Ökonomische und damit verbundene normative Begründungen führten und führen zu gesellschaftlicher Ausgrenzung. Diese gilt es heute in Zeiten von ökonomischen Krisen, Existenzrisiken und Geringbeschäftigungsverhältnissen zu überwinden. Solange gesellschaftliche Ausgrenzung und soziale Ungleichheit nicht als allgemeines gesellschaftliches Problem verstanden und in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung um Inklusion gestellt werden, kann Inklusion zwar in individuellen Zusammenhängen gelingen, führt aber nicht zur generellen Überwindung der gesellschaftlichen Widersprüche. Der von zunehmenden Ausgrenzungsprozessen gekennzeichneten

Situation steht die in der UN – BRK formulierte Vorstellung von einer inklusiven Gesellschaft entgegen, einem Gemeinwesen, das alle seine Mitglieder in ihrer Subjektivität und Unterschiedlichkeit wertschätzt.

Die Begegnungen mit Heterogenität, mit den vielfältigen und unterschiedlichen Formen und Ausprägungen von Diversität auf individueller und organisatorischer Ebene sowie des persönlichen und gesellschaftlichen Umgangs damit ist zentraler Gegenstand der

Behandlung des Stoffs. Somit trägt dieser in seiner diskursiven Behandlung zur Ausprägung einer klaren heilpädagogischen Haltung bei.

Sybille Lenk

### **Heilpädagogisches Handeln unter berufsethischem Aspekt**

Unter dem Thema „Heilpädagogisches Handeln unter berufsethischem Aspekt“ ist die Sterbe- und Trauerbegleitung in der heilpädagogischen Arbeit als ein wesentlicher Inhalt aufgeführt.

Zum Begriff der Sterbebegleitung und Trauerverarbeitung sind in der Fachliteratur unterschiedliche Modelle des Copingprozesses meist in Phasen- oder Spiralfarm verfügbar und sollten im Unterricht in geeigneter Form vorgestellt und erläutert werden. Dabei eignen sich für die Vertiefung und Reflexion biografische Zugänge – sofern diese eröffnet werden können – sehr gut.

Außerhalb klinisch – therapeutischer Deutung und Erfahrung werden diese Modelle oft in der belletristischen Literatur abgebildet.

Hier ist ein erwachsenenspezifischer Zugang über literarische Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglich, indem man darum bittet, Literatur zur entsprechenden Thematik mitzubringen und vorzustellen.

In der Vorstellung der Bücher hat es sich als sinnvoll erwiesen, den Unterricht so zu strukturieren, dass man als Lehrerin oder Lehrer zunächst Kinderbücher, danach Jugendbücher und erst zum Schluss für erwachsene Leser verfasste Bücher vorstellen lässt.

Erfahrungsgemäß wird auch das eine oder andere Sachbuch mitgebracht bzw. Bücher, die in die Kategorie „Erfahrungsbuch Betroffener oder betroffener Angehöriger“ einzuordnen sind. Diese würde ich von der Belletristik abgrenzen, jedoch einbeziehen.

Wichtig ist in der Vorbereitung des Unterrichtes darauf zu achten, dass man selbst möglichst viele Bücher mitbringt und mit dem Focus auf die Thematik vorstellt.

Fündig wird man neben Bibliotheken inzwischen auch in Datenbanken zur narrativen Heilpädagogik (z. B. [www.erzaehltebehinderung.ch](http://www.erzaehltebehinderung.ch))

Der Vorteil des oben beschriebenen Herangehens besteht darin, dass sich die Teilnehmer der Thematik diskursiv nähern und somit u. U. auch durch den Perspektivwechsel ihre Haltung reflektieren. Dabei stellen sie Bezüge zu literarischen Vorerfahrungen her und werden oft zum Lesen motiviert.

Sie betrachten die Einsatzmöglichkeiten von Literatur in der Krisenbewältigung unter dem Focus von poetisch verdichteten Texten.

Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass in der Regel in jeder Klasse sehr belesene Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, die hier die Möglichkeit haben, ihre besondere Kompetenz in den Unterricht einzubringen.

Darauf sollte man wertschätzend eingehen.

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Suche nach Abbildungen heilpädagogischer Themen in der schöngeistigen Literatur immer lohnend ist und die Reflexion vieler Themen in der Allgemeinen Heilpädagogik vertieft.

Sybille Lenk

## **Kompetenzorientierte Leistungsbewertung im Ausbildungsgang Staatlich anerkannter Heilpädagoge/staatlich anerkannte Heilpädagogin**

### Vorüberlegungen

#### Modul 1

---

Interaktionsmodell der Entstehung von Behinderungszuständen auf ein Beispiel aus der eigenen Praxis beziehen

Belegarbeit „Heilpädagogische Einrichtungen und Dienste“

Vorstellung des eigenen Arbeitsbereiches und Reflexion der eigenen heilpädagogischen Tätigkeit (Darstellung in einer Gruppenpräsentation entsprechend der Arbeitsfelder)

Fallbearbeitung: Hilfeplanung als Leistungskontrolle unter Zuhilfenahme aller Aufzeichnungen (im Zusammenhang mit den Themen Inklusion und Persönliches Budget unter dem Gesichtspunkt des Paradigmenwechsels)

Klassenarbeit zur heilpädagogischen Beziehungsarbeit (Transfer auf ein Praxisbeispiel gelungener oder misslungener Beziehungsgestaltung)

Zusammenfassende Darstellung eines wissenschaftlichen Fachtextes zu einem prüfungsrelevanten Thema in Form eines Kurzvortrages

#### Modul 13 (Heilpädagogische Spielbegleitung)

---

Anwendung/Erprobung eines projektiven Testverfahrens mit Protokoll/Auswertung und Präsentation des Ergebnisses

Belegarbeit zur heilpädagogischen Spielbegleitung (Bewertung der theoretischen Darstellung und des Praxistransfers) - Diese bezieht sich entweder auf die Person in der Heilpädagogischen Förderung oder auf eine Gruppe.

Gestaltung einer Unterrichtseinheit zu einem selbst gewählten Thema (z. B. Theaterspielen mit Menschen mit geistiger Behinderung, Spiele zur Wahrnehmungsförderung) - Hier fungiert der Fachschüler als Spielleiter in der Unterrichtsgruppe und reflektiert seine Erfahrung als Prozessbegleiter.

Sybille Lenk

## **Bundesteilhabegesetz**

Die Vermittlung von Rechtskenntnissen stellt im Modul einen Aspekt dar, der die Behandlung aller Themen berührt. Dem Gesetz zur Stärkung zur Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) kann man sich im Unterricht gut aus historischer Sicht nähern.

So lässt sich der Paradigmenwechsel – heraus aus der vom Fürsorgegedanken geprägten „Armengesetzgebung“ im SGB XII hin zum davon abgegrenzten Leistungsgesetz/Schwerbehindertenrecht im SGB IX gut verdeutlichen. Dies entspricht den seit langem bestehenden Forderungen von Selbsthilfeverbänden von betroffenen Menschen. (Independent living, People first, Krüppelbewegung, Selbstbestimmt leben e.V. usw.)

Dazu kommt, dass sich die Bundesrepublik Deutschland durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention dazu bekannt hat, das deutsche Recht grundsätzlich in Übereinstimmung mit diesem Menschenrechtsübereinkommen weiterzuentwickeln.

Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen bei den Vereinten Nationen hat für die Bundesrepublik Deutschland eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen gegeben. Als Folge dieser Empfehlungen wurde die gesetzliche Definition von Behinderung mit den allgemeinen Grundsätzen der UN – Behindertenrechtskonvention in Einklang gebracht (§ 2 Bundesteilhabegesetz)

Auch hier bietet sich der historische Ansatz der Stoffvermittlung in Hinblick auf den Wandel des Behinderungsbegriffes an.

Das gleiche gilt für die Behandlung der Forderung nach Weiterentwicklung der Deinstitutionalisierung genauso wie für die Paragraphen zur Selbstbestimmung und Inklusion in Bezug auf die Wahl des Lebensortes.

Eher erfahrungsbasiert ist die Forderung des Gesetzes, Leistungen „wie aus einer Hand“ zu erbringen, um zeit- und kostenintensive Zuständigkeitskonflikte der Rehabilitationsträger untereinander sowie teure Doppelbegutachtungen zu vermeiden, zu diskutieren. (vgl. Steuerungsinstrumente in den Hilfen zur Erziehung/Steuerungsfähigkeit der Eingliederungshilfe)

Dabei spielt auch die unabhängige Teilhabeberatung (z. B. im Rahmen des Peer Support) eine für Heilpädagogen und Heilpädagoginnen wichtige Rolle. Gegebenenfalls tut sich hiermit für diese Berufsgruppe ein neues Arbeitsfeld auf und sollte so auch vermittelt werden. Die Herauslösung der reformierten Eingliederungshilfe aus dem SGB XII (Sozialhilfe) und deren Überführung in „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ stellt eine tatsächliche Aufwertung durch ein eigenständiges Leistungsgesetz dar. Dies sollte im Unterricht verdeutlicht werden.

Hierbei ist es wichtig, auf das Wohnortprinzip entsprechend der kommunalen Daseinsvorsorge zu verweisen.

Es bleibt z. Z. noch offen, inwiefern der § 99, der den leistungsberechtigten Personenkreis regelt, in der jetzigen Form erhalten bleibt.

Außerdem sind Regelungen z. B. zum Vermögensaufbau oder zur Komplexleistung Frühförderung noch in Bewegung. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Sybille Lenk

## **Modul 2** „Medizinische Grundlagen“ *Empfehlungen zur inhaltlichen Gestaltung*

Der Modulinhalt stellt im Verhältnis zur Einheit des Gesamtlehrplanes die Basis für die heilpädagogische Diagnostik und Förderung der Klienten<sup>2</sup> dar.

Eine Stundenverteilung mit 3 im ersten Halbjahr und 2 im zweiten ist empfehlenswert. Noch besser wäre ein Abschluss des Moduls im ersten Halbjahr der Ausbildung, um anwendungsbereites Basiswissen zu ermöglichen.

Hinsichtlich der beschriebenen personalen und sachlichen Kompetenzen steht im Mittelpunkt des Moduls die Fachsprache als Mittel zur interdisziplinären Zusammenarbeit sowie das grundlegende Verstehen der anatomischen und physiologischen Strukturen des menschlichen Körpers. Beide Komponenten sollen die Fachschüler befähigen sich eigenständig neue medizinische Grundlagen zu erschließen.

Als Reihenfolge der Vermittlung der Lehrinhalte (siehe Inhalte Modul) schlagen wir vor:

- Einführung der diagnostischen Methoden und Therapien in der Übersicht und ergänzend alternative Heilmethoden
- Nervensystem incl. Entwicklung und Neurologie/Wahrnehmungsverarbeitung
- Prä-, peri- und postnatale Pathogenese und Therapie von Störungsbildern
- Bewegungssystem incl. Pathogenese und Therapie von Störungsbildern
- Herz-Kreislauf- und Atmungssystem
- andere Systeme und Erkrankungen (siehe Modulinhalte) nach Relevanz für die Förderung und individueller, schulischer Schwerpunktsetzung

Ausgehend von zu erwerbenden spezifischen Kenntnissen über die Hirnfunktionen empfehlen wir in den Focus dieses Abschnittes auch die prä- und postnatale Entwicklung des Nervensystems zu stellen und dabei einen Schwerpunkt im Bereich pränataler Bindungstheorien im Zusammenhang mit der strukturellen und funktionalen neurologischen Entwicklung zu setzen.

Die Diagnostik zur Anamnese des Klienten zeigt die Bedeutung dieser Thematik als Erklärung bestimmter postnataler Phänomene.

Die Lehrinhalte der frühkindlichen Reflexe einschließlich fehlender und verzögerter Hemmung bzw. Integration ergeben sich zum einen logisch aus der Entwicklung des kindlichen ZNS, zum anderen ist auf dieser Basis eine entsprechende Interpretation kognitiver und postnataler Störungsbilder möglich.

Als Ursache von Verhaltensauffälligkeiten, einer unzureichenden grob- und feinmotorischen Entwicklung oder einer schwierigen Lernproblematik bei deutlich vorhandener Intelligenz können heute überwiegend in der Fachliteratur und im praktischen Erleben der Schüler, persistierende Restreflexe angesehen werden. Eine Studie des Kultusministeriums Hessen innerhalb eines Projektes<sup>3</sup> zu Wahrnehmungsbereichen, Gleichgewicht und Lernverhalten von Kindern bestätigt diesen Zusammenhang und gibt Empfehlungen zur Bearbeitung dieser Problematik im Rahmen von gezielten Bewegungsübungen.

Hier empfiehlt sich eine Vertiefung in den Modulen KM 4, KM 9, KM 12, KM 13, KM 15 und KM 18.

Daher empfehlen wir die Schwerpunktsetzung hinsichtlich der neurologischen Grundlagen, der pränatalen neurologischen Entwicklung, der frühkindlichen Reflexe sowie die Ableitung entsprechender Störungsbilder.

Alle anderen im Lehrplan bezeichneten Organsysteme als anatomische und funktionelle Einheiten empfehlen wir hinsichtlich ihrer Bedeutung für den individuellen Förderprozess zu hinterfragen und entsprechend nachzulernen.

Christine Hockauf

---

<sup>2</sup> hier als verallgemeinerte Form, impliziert alle Geschlechter

<sup>3</sup> Hessisches Kultusministerium 2007 und ff., Projekt: „Schnecke – Bildung braucht Gesundheit“, Gegenstand: Hören, Sehen und Gleichgewicht, online als Broschüren verfügbar

### **Modul 3 „Psychologisch-psychiatrische und soziologische Grundlagen heilpädagogischen Handelns“**

#### **Teilmodul 1: Psychologische Grundlagen heilpädagogischen Handelns**

##### **Kompetenzen:**

*Die Fachschüler erkennen die Bedeutung psychologischer Betrachtungsweisen für heilpädagogisches Handeln und können theoretische Auffassungen im Hinblick auf heilpädagogisches Handeln vergleichen und kritisch werten.*

Die Fachschüler werden aufgefordert, eine markante Situation aus ihrem Arbeitsalltag (pädagogische Arbeit in der Gruppe, heilpädagogische Arbeit, Beratung im Team, Arbeit mit Angehörigen) darzulegen, in der sie

- bewusst auf psychologische Einsichten zurückgegriffen haben und ihr pädagogisches/heilpädagogisches Handeln danach ausrichteten,
- Kolleginnen offen oder verdeckt ein anderes Modell psychologischen Denkens angewendet haben,
- gern psychologische Erkenntnisse zur Anwendung gebracht hätten, um erfolgreicher zu sein, über die sie aber nicht verfügten.

In Kleingruppen erfolgt ein erster Austausch über die Erfahrungen und eine Auswahl interessanter Situationen.

Im Plenum werden nach Vorstellung der Situationen Fragen diskutiert, wie:

- Wie verfügbar, wie umfangreich, wie detailliert ist unser psychologisches Wissen?
- Welche Alltagstheorien wende ich an? Welche alternativen Denkweisen sind möglich?
- Sind meine subjektiven Theorien wissenschaftlich fundiert? Wie überprüfe ich das?
- Welche psychologischen Fragestellungen stehen im Vordergrund?
- Welche Erwartungen habe ich an die psychologische Wissenschaft? Wie realistisch sind sie?

Zusammenfassend können folgende Thesen dialektisch gegenübergestellt werden:

- A In der heilpädagogischen Praxis muss man Individuum bezogen, engagiert, verantwortungsbewusst, konkret denken und handeln.
- B Wissenschaftliches Denken muss systematisch, präzise, abstrakt und theoriegeleitet sein.

Als Erkenntnis sind die Bereitschaft und die Vornahme wünschenswert, sich mit dem eigenen naiven Denken und Handeln bewusst auseinanderzusetzen und psychologische Erkenntnisse zu vertiefen. Auf dieser Basis werden Hauptinhalte des Lehrplans vorgestellt. Die Fachschüler können für sie bedeutsame Themen einbringen, die der Lehrer gegebenenfalls in die Systematik einordnet.

Psychologie wird (wiederholend) definiert als die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten und den Bedingungen, unter denen sie sich realisieren und entwickeln.

Das Verhältnis zwischen Erleben und Verhalten wird als Verhältnis zwischen Innen und Außen gekennzeichnet. Die subjektiv erlebte Lebenslage wird unter Bezugnahme auf die erinnerte Lebensgeschichte und die phantasierte Lebensperspektive als Entwurf verstanden. Dabei kann schwerpunktmäßig betrachtet werden:

- Mehrdeutigkeit der Beziehung zwischen Erleben und Verhalten,
- Lebensraum als Verschränkung von Person und Umwelt, hier wirken Kräfte, die das Erleben und Verhalten bestimmen, "Wirklich ist, was wirkt."
- subjektive Konstruktion von Abbildern und Repräsentationen der Wirklichkeit, Annäherung dieser Abbilder im sozialen Austausch,

- Veränderung der äußeren Wirklichkeit durch Handeln,
- Veränderung der inneren Wirklichkeit durch Abwehr und kognitive Umstrukturierung.

*Aber:* Es gibt nicht die richtige Art, Psychologie zu betreiben, sondern verschiedene, historisch gewachsene Richtungen. Psychologie ist aspektivisch.

Im Sinne eines Lernplakats werden in Kleingruppenarbeit Hauptrichtungen der Psychologie vorgestellt (psychodynamische Theorien, Behaviorismus, kognitive Psychologie, humanistische Psychologie). Inhaltliche Schwerpunkte können dabei sein:

- historischer Hintergrund, Vertreter,
- Kernaussagen, Menschenbild, Auffassungen zur Persönlichkeit und deren Entwicklung,
- Störbarkeit der Entwicklung,
- Bezug zum heilpädagogischen Handeln insbesondere im Hinblick auf das Verstehen besonderer Erlebnis- und Verhaltensweisen und deren Beeinflussbarkeit,
- kritische Wertung,
- Anekdoten,
- offene Fragen.

Eine Praxissituation sollte auf der Basis der verschiedenen Schulen analysiert werden. Ein Denkanstoß könnte sein:

Eine Mitarbeiterin berichtet ärgerlich, dass der Zahnarztbesuch mit Herrn R. (Bewohner einer Wohn Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung) gescheitert ist. Sie habe Herrn R. am Vortag und auch nach dem Frühstück des betreffenden Tages das Vorhaben vorgestellt. Außerdem habe sie ihm eine Belohnung versprochen. Er sei zwar mit ins Wartezimmer gekommen, war aber durch nichts zu bewegen, auf dem Behandlungsstuhl Platz zu nehmen. Kurz vor der Ankunft im Wohnheim habe Herr R. darum gebeten, es noch mal zu versuchen. Darauf sei sie aber nicht eingegangen, weil Herr R. merken soll, dass sein Verhalten Konsequenzen hat.

***Lerntheoretischer Ansatz:***

Sicht von Herrn R.: frühere Lernerfahrungen, Schlüsselreize, Belohnung als positiver Verstärker (?), Ausweichen als negativer Verstärker, Kontingenz

Sicht der Mitarbeiterin: Menschenbild, Kontrolle der Bedingungen

***Psychodynamischer Ansatz:***

Sicht von Herrn R.: Ängste, Integrität des Körpers, Funktionen des Ich, Übertragungen, Minderwertigkeitsgefühle

Sicht der Mitarbeiterin: Ängste, Funktionen des Über-Ich, Gegenübertragung, Scham

***Kognitionspsychologischer Ansatz:***

Sicht von Herrn R.: Wahrnehmung, Problemlösestrategien, Stress

Sicht der Mitarbeiterin: Wahrnehmung, Attribution

***Ansatz der humanistischen Psychologie:***

Sicht von Herrn R.: Bedürfnishierarchie, Selbstkonzept, Autonomie

Sicht der Mitarbeiterin: Empathie, Spiegelung emotionaler Befindlichkeit, Duldung von Umwegen

Die verschiedenen Deutungen werden kritisch hinterfragt und im Hinblick auf künftiges Handeln bewertet.

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit kann auf die vertiefende Betrachtung einiger Aspekte in den folgenden Stunden verwiesen werden.

## Teilmodul 2: Soziologische Grundlagen heilpädagogischen Handelns

### Zum Thema „Die Stellung von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft“

Inklusion unter soziologischem Aspekt bedeutet das strukturelle Einbezogen sein aller Mitglieder einer Gesellschaft in all ihre Funktionsbereiche und deren gleichberechtigte Teilhabe an ihnen. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen erleben bei der Mitgestaltung inklusiver Prozesse gesellschaftliche Widersprüche, die ein Ausdruck nach wie vor bestehender und sich zum Teil verschärfender sozialer Ungleichheit sind. Eine soziologisch historisierende Sichtweise kann dabei unterstützen, gesellschaftliche Prozesse der Exklusion und Inklusion zu erkennen, aufzudecken und eine gewünschte gesellschaftliche Dynamik zu befördern.

Die Komplexität gesellschaftlicher Entwicklung wird auch daran deutlich, dass verschiedene soziologische Theorien soziale Ungleichheit beschreiben und erklären. Pointiert und mit kritischer Distanz können die grundlegenden Aussagen von Rousseau, Marx, Weber, Geiger, Parsons, Moore, Schelsky, Bergmann, Bolte, Bourdieu, Dahrendorf, Beck und Hradil vertieft und ergänzt werden. Entscheidend ist dabei das Nachdenken über Fragen, wie beispielsweise:

Haben die sozialen Unterschiede zwischen Menschen eine natürliche Grundlage?  
Sind soziale Schichtungen nach dem Kriterium der Leistung für eine Gesellschaft funktional, sind sie gerecht?

Welche Denkanstöße lassen sich aus den Prinzipien der „Vergesellschaftung“ und der „Vergemeinschaftung“ (Max Weber) ziehen?

Wie erleben Menschen ihre objektive Soziallage subjektiv? Welche Ursachen hat das?

Was macht Lebensqualität aus?

Welche Risiken sind mit einer individualisierten Gesellschaft verbunden?

Welche Merkmale können potenziell zu doppelter Benachteiligung führen?

Der Diskurs kann mit einem Vers von Bertold Brecht eröffnet werden:

„Reicher Mann und armer Mann

standen da und sah`n sich an.

Und der Arme sagte bleich:

Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“

Eine intensive und emotionale Auseinandersetzung mit der Stellung von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft mit neuen Handlungschancen und differenzierten Lebenszielen, aber auch Tendenzen zu Konsumterror, Inszenierung des Körpers und Kommerzialisierung aller Lebensbereiche wird durch folgende Aussagen angeregt:

„Hat ihr Kind zufällig das Down-Syndrom? Nein? Schade. Oder ist es mit einer körperlichen Behinderung zur Welt gekommen? Auch nicht? Ja, leidet es wenigstens unter Spasmen, weil es bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen hat? Sie sind mir vielleicht ein Verlierer- und ihr Kind auch. Denn schließlich ist nur behindert wirklich besonders. Nur wer behindert oder krank ist, kann in Zukunft Karriere machen- die Modebranche schreitet schon mal voran.... Schauen Sie sich z.B. mal Jamie Brewer an. Sie hat zwar das Down-Syndrom, aber das macht nichts. Oder besser gesagt: Das ist eigentlich gut, denn Jamie Brewer ist damit „ziemlich einzigartig“, findet die Website [gofeminin.de](http://gofeminin.de): „Obwohl sie am Down-Syndrom leidet, arbeitet die junge Frau als Schauspielerin (American Horror Story) und ist aktiv für die Arc oft the United States, eine Organisation, die Menschen mit geistiger Behinderung und Entwicklungsbeeinträchtigungen unterstützt.“ Daumen hoch! Das ist „cool“! Na, bitte - und was stellt ihr blog auf die Beine? Jamie Brewer revolutioniert immerhin die Fashion Welt: Für Designerin Carrie Hammer sollte Jamie im Februar 2015 ein Kleid auf der New York Fashion Week präsentieren. Sie ist „das erste Modell mit Down-Syndrom, das über den Catwalk läuft.“



Ist das nicht toll? Und ob: „Wir sind begeistert.“ Jubelte [gofeminin.de](http://gofeminin.de) am 12. Februar 2015. Wir natürlich auch. Und zwar, weil solche armen behinderten Wesen nun mal nicht arm und behindert, sondern „echte Frauen“ sind: Man hoffe, so [gofeminin.de](http://gofeminin.de), „dass noch viele weitere Designer auf echte Frauen setzen und nicht nur die superschlanken Models über den Catwalk stolzieren lassen“ Geht es nach „Designerin“ Carrie Hammer, sollen die Models auf dem Laufsteg nicht einfach Klamotten von A nach B tragen, sondern neue Rollen formen, wofür sie schon mal den Slogan „Role Models not runway Models“ geprägt hat- also „Rollenmodelle statt Laufstegmodelle.“ Kurz: Die Schönheit soll aus der stilprägenden Modewelt verschwinden Die schönen und gesunden Vorbilder sollen weg. ... Das Magersucht-Vorbild soll nun durch das behinderte Vorbild ersetzt werden. ...

Z. B. wird schon seit geraumer Zeit Das Wort „behindert“ und „besonders“ verknüpft. „Behindert. Besonders. Anders.“ titelt z. B. der Behindertenbeirat München. Um nicht zu sagen: „Behindert ist einfach toll.“ ...

Na, bitte: Und damit kann man richtig Karriere machen. Denn schließlich braucht man diese „Mängel“ durchaus nicht verstecken ....

Kurz: Gaydos und ihre kranken und behinderten Kolleginnen werden zu ganz großen Vorbildern aufgebaut. ...

Inzwischen gibt es sogar eine eigene Agentur für „Models mit Makel“: Die Modelagentur MisfitModels rollt die Schönheitsindustrie von hinten auf, schrieb das Jubelblatt „Die Welt“ am 14. April 2015 in seinem Moderesort. Gründer Del Keens sucht nach Menschen mit Tattoos, Makeln oder Behinderung....“

*Auszug aus: Gerhard Wisniewski, Neuester NWO-Trend: Behinderte Models als Vorbilder, [netzwerkpforte.de](http://netzwerkpforte.de)*

Die wirkliche Absicht des Autors ist zwar schwer ergründbar, die teils sarkastisch, teils rückwärts gerichteten Formulierungen regen aber zum Nachdenken darüber an, dass der Prozess der Inklusion widersprüchlich ist, nicht von allen gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen getragen wird und die Gefahr des Missbrauchs persönlichen Engagements durch Kommerz besteht.

Sozusagen als Gegenentwurf können die Lernenden aufgefordert werden, einen Jahreskalender anzufertigen, in welchem sie mit der Haltung einer Heilpädagogin/eines Heilpädagogen die gesellschaftliche Stellung von Menschen mit Behinderung reflektieren. Aufgabenstellung:

Gestalten Sie unter Nutzung vielfältiger künstlerischer Mittel einen Kalender, in dem Sie die Stellung von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft systematisch thematisieren.

Diskutieren Sie Ihr Anliegen in Ihrem Arbeitsteam. Reflektieren Sie Ihre Arbeit und wenden Sie dabei bewusst soziologische Kategorien an.

Die Vorstellung des Kalenders einschließlich der Reflexion wird bewertet.

Gleichberechtigte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben ist Voraussetzung für echte Demokratie. Die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit zu demokratischem Handeln ist Teil der Sozialisation und muss deshalb auch zum Anliegen einer Heilpädagogin/eines Heilpädagogen gehören. Im Rahmen der unterschiedlichen Handlungsfelder können die Fachkräfte Demokratie durch Partizipation erlebbar machen. Im Unterricht sollen deshalb positive Erfahrungen ausgetauscht und Bedingungen erkannt werden, die die Beteiligung erleichtern, Machtmissbrauch verhindern und damit zu gelungener Sozialisation beitragen.

Der Austausch kann durch die Aufforderung, einen „Partizipationscheck“ des eigenen Arbeitsbereiches anzufertigen, angeregt werden:

-> Kommunikationsstruktur in der Einrichtung,

-> offizielle und inoffizielle Regeln, deren Erarbeitung, Bekanntheitsgrad, Funktionen,

## Didaktisch-methodische Handreichungen zu den Modulen

Einhaltung, Sanktionen,

- > Gremien der Mitbestimmung, ihre Arbeitsweisen,
  - > Transparenz von Entscheidungen und Planungen,
  - > Umgang mit kritischen Stimmen, Beschwerderecht, Beschwerdemöglichkeiten,
  - > Bereitstellen von Informationen und Hilfen, die Beteiligung ermöglichen,
- Anwenden der leichten Sprache,
- > Aushandeln von Interessenkonflikten, Umgang mit Ärger und Enttäuschung
  - > Visionen, Zukunftswerkstatt.

Das Anliegen kann so zusammengefasst werden:

Partizipation:- regt an, statt zu manipulieren,

- schlägt vor, statt anzuweisen,
- motiviert, statt einzuengen,
- bestärkt, statt zu kritisieren,
- unterstützt, statt Grenzen zu zeigen.

Dr. Ulrike Engert

### **Teilmodul 3: Psychologisch-psychiatrische Grundlagen heilpädagogischen Handelns**

In allen Arbeitsfeldern können Pädagogen auf Menschen treffen, die psychisch erkrankt sind. Für Heilpädagogen ist es eine besondere Herausforderung, Menschen mit psychischer Störung mit und ohne Behinderung mit Respekt vor ihrem Anderssein zu begegnen und sie bei ihrer selbstbestimmten Entwicklung zu unterstützen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden und um für den Anderen im Sinne der Care-Ethik einzutreten, sind profunde Kenntnisse über die Vielzahl psychischer Störungen und ihrer Erscheinungsformen unverzichtbar.

Als Raster zum systematischen und praxisorientierten Erkenntnisgewinn wird vorgeschlagen:

- (1) Fallbeispiel, Beschreibung von Symptomen und des Zustandsbildes im Vergleich zur (möglichen, vermuteten) Selbsterleben der Lebenswelt des Betroffenen,
- (2) Einordnung nach ICD 10, Diagnostik
- (3) Prävalenz,
- (4) Ursachen und aufrechterhaltende Bedingungen,
- (5) therapeutische Ansätze,
- (6) Möglichkeiten heilpädagogischer Arbeit,
- (7) Besondere Bedingungen bei Menschen mit geistiger Behinderung.

Einige Ausführungen zur Zwangserkrankung sollen dieses Vorgehen demonstrieren.

#### **zu 1**

Frau Arnold, 32 Jahre, wohnt seit Jahren in einer betreuten Wohngruppe und hat eine leichte geistige Behinderung. Von Anfang an legte sie großen Wert auf persönliche Hygiene und verbrachte viel Zeit mit Waschen und Duschen, wofür sie viel Lob erhielt. Dieses Verhalten wurde zum Waschwang, der Frau Arnold von anderen Aktivitäten abhält. Sie ist unzufrieden damit, dass sie an Angeboten nicht teilnimmt, weil sie sich vor Beschmutzung fürchtet oder das Angebot zum Waschen verlässt. Frau Arnold wirkt unruhig, wenn sie am Ausüben ihres Waschwangs gehindert wird. Sie schaut in verschiedene Richtungen, läuft ziellos durch den Raum, gibt Geräusche von sich. Auf Ansprache reagiert sie verzögert. Sie weiß aber, dass zu häufiges Waschen ungesund ist.

Symptome: Waschen, Duschen als zwanghaftes Verhalten, auch spontan während Angeboten, bereits über Wochen, Frau Arnold kann sich dem Zwang nicht entziehen, erlebt ihn als unangenehm

Selbsterleben: Sauberkeit zeichnet mich aus, Alltag ist anstrengend. Ich will sauber sein, das schützt mich, aber ich wasche mich zu lange und will auch an den schönen Dingen teilnehmen. Das schaffe ich nicht.

#### **zu 2**

##### **F 42.1 Zwangsstörung**

A Entweder Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen (oder beides) an den meisten Tagen über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen.

B Die Zwangsgedanken (Ideen oder Vorstellungen) und Zwangshandlungen zeigen sämtliche folgenden Merkmale:

1. Sie werden als eigene Gedanken/Handlungen von den Betroffenen angesehen und nicht als von anderen Personen oder Einflüssen eingegeben.
2. Sie wiederholen sich dauernd und werden als unangenehm empfunden und mindestens ein Zwangsgedanke oder eine Zwangshandlung werden als übertrieben und unsinnig anerkannt

3. Die Betroffenen versuchen, Widerstand zu leisten (bei lange bestehenden Zwangsgedanken und Zwangshandlungen kann der Widerstand allerdings sehr gering sein). Gegen mindestens einen Zwangsgedanken oder eine Zwangshandlung wird gegenwärtig erfolglos Widerstand geleistet.
  4. die Ausführung eines Zwangsgedankens oder einer Zwangshandlung ist für sich genommen nicht angenehm (dies sollte von einer vorübergehenden Erleichterung von Spannung und Angst unterschieden werden)
- C Die Betroffenen leiden unter den Zwangsgedanken und Zwangshandlungen oder werden in ihrer sozialen oder individuellen Leistungsfähigkeit behindert, meist durch den besonderen Zeitaufwand.
- D Häufigstes Ausschlusskriterium: Die Störung ist nicht bedingt durch eine andere psychische Störung, wie Schizophrenie und verwandte Störungen (F2) oder affektive Störungen (F3).

Diagnostik, **Inventare:**

- Yale-Brown-Obsessive Scale (Y-BOCS), für Kinder: Children`s Y-BOCS,
- Hamburger Zwangsinventar (HZI),
- Padua-Zwangsbogen (Padua-R),
- Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory

Zwangssymptome treten in Form von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen auf, unter deren wiederholtem, nicht beherrschbarem und gleichzeitig als unsinnig erlebtem Auftreten der Betroffene leidet. Die Symptome werden als eigene Gedanken und Impulse eingeordnet. Die Zwangsgedanken werden als unangenehm erlebt, weil sie Unsicherheit und Angst auslösen. Durch Zwangshandlungen können diese Ängste reduziert werden. Zwangssymptome können sich so ausweiten, dass sie den Alltagsablauf erheblich erschweren.

häufige Zwangsgedanken: Furcht vor Schmutz, Sekreten, Krankheitserregern, Furcht vor eigenen aggressiven oder sexuellen Impulsen, Zweifel an eigener Handlungskompetenz

häufige Zwangshandlungen: Waschwänge, Kontrollwänge, Wiederholungswänge, Zählwänge, Berührungswänge, Sammelwänge

**zu 3**

Jahresprävalenz für Erwachsene ca. 2%, für Kinder ca. 0,7% unabhängig von sozialer Lage und Intelligenz

Frauen: häufiger Waschwänge, Verlauf eher akut, durchschnittlicher Beginn bei 25 Jahren

Männer: häufiger Ordnungswänge, Verlauf eher schleichend, durchschnittlicher Beginn bei 20 Jahren

Verlauf insgesamt: 44% chronisch, 31% intermittierend, 10% episodisch

**zu 4**

- tiefenpsychologisch: anale Phase, Unterdrückung aggressiver Impulse aus dem Es, starke Schuld- und Schamgefühle, Wunsch die Impulse zu beherrschen, Es-Impulse manifestieren sich als Zwangsgedanken, Abwehr als Zwangshandlung
- lerntheoretisch: Unsicherheiten und Ängste werden durch Zwangsrituale reduziert (negative Verstärkung). Diese führen aber zu Scham und sozialer Isolierung, was wiederum die Zwanghaftigkeit verstärkt.
- persönliche Disposition (Aufmerksamkeit verstärkt auf Angstreize gerichtet, negative Informationen länger im Gedächtnis präsent)

## Didaktisch-methodische Handreichungen zu den Modulen

- neurobiologisch: Störungen im Serotoninhaushalt
- traumatisches Erlebnis als Auslöser

### zu 5

- medikamentöse Behandlung mit Antidepressiva (selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer, z. B. Fluoxetin, Paroxetin, Zolofol)
- Verhaltenstherapie: sich den Ängsten stellen, ohne auf Zwangsrituale zurückzugreifen (Exposition und Reaktionsverhinderung)

### zu 6

Ziel ist, dass der Betroffene, die Kontrollen über seine Zwänge gewinnt und sie akzeptiert. Die folgenden Herangehensweisen basieren auf unterschiedlichen theoretischen Ansätzen und müssen individuumsbezogen ausgewählt werden.

- Ressourcen ermitteln und diese im Alltag verstärken
- Vereinbaren und Realisieren von Zeiten, in denen dem Zwang nicht nachgegeben wird
- Vereinbaren und Realisieren von Räumen, in denen dem Zwang nicht nachgegeben wird
- Zwang einzwängen, indem er in einem festen Rhythmus an einem bestimmten Ort ausführlich durchgeführt wird, unangenehme Gedanken sollen in dieser festgelegten Zeit zugelassen werden
- Rückwärtszählen, gemeinsam oder durch Klienten, bei 0 Stopp für den Zwang
- Personalisierung des Zwangs, gegen den angekämpft wird
- „Mutprobe“: Konfrontation mit Auslösern der Zwänge und Aushalten der Ängste bis Habituation
- Anleitung für normale Verrichtung von Alltagshandlungen verbunden mit Limitierungen von Zeit und Utensilien
- Gespräch: Was nützt es mir, diesen Zwang zu haben? Wie könnte der Zwang mein Freund werden? Woran merke ich, dass ich besser mit dem Zwang leben kann?

Reframing anregen: Der Zwang gibt meinem Leben Struktur. Er verschafft mir Pausen.

- Vorhersagekalender: Bewusstsein wird auf Fähigkeit des Vorhersagens gelenkt, sodass Gefühl der Machtlosigkeit verringert wird
- euthyme Verfahren: „Genusstraining“ durch differenzierte Wahrnehmung, Achtsamkeit, Fantasieren

### zu 7

Verhaltensweisen wie gleichförmige Bewegungen oder stereotype Äußerungen können mit Zwängen verwechselt werden. Menschen mit geistiger Behinderung erlangen mitunter keine Einsicht in ihr zwanghaftes Verhalten oder Denken. Ob ein Leidensdruck vorliegt, ist schwer zu erkennen. Wichtig ist es abzuschätzen, inwiefern die Lebensqualität beeinträchtigt ist.

Zur Erkenntnissicherung sollte das Fallbeispiel erneut diskutiert werden.

Dr. Ulrike Engert

## **Modul 4 „Grundlagen der Diagnostik und Förderung von Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten“**

### **Teilmodul 1: Grundlagen der Diagnostik und Förderung von Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten**

In dieser Handreichung zum Kernmodul 4, Teil I steht die Vermittlung von **Grundlagen der Heilpädagogischen Förderdiagnostik bei Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten** im Mittelpunkt der Betrachtung.

Die methodischen Anregungen orientieren sich an den zu erwerbenden Kompetenzen der Fachschüler. Es sind Empfehlungen und ausgewählte Aspekte, die in dieser Form nicht bindend, sondern beispielhaft sind und jedem unterrichtenden Fachschullehrer obliegt es, eigene individuelle Schwerpunkte zu setzen. Dies gilt im Besonderen für die Auswahl der „Anträge auf Gewährung von Eingliederungshilfe“ bei den Sozialträgern, wobei hier auf regionale Unterschiede hingewiesen werden sollte sowie der Auswahl von personenorientierten Tests bzw. Überprüfungsverfahren und der Fachliteratur zur Erstellung der Heilpädagogischen Förderdiagnostik.

Inhalte:

- Erläuterungen zu den Begriffen Heilpädagogische Förderung (HPF) und Heilpädagogische Fördereinheit (HPFE) im neuen Lehrplan
- Gesetzliche Grundlagen der HPF sowie Beantragungsverfahren zur Gewährung von Eingliederungshilfe durch die jeweiligen kommunalen Sozialträger
- Kurzcharakteristik der Heilpädagogischen Förderdiagnostik (HPFD)
- Gesamtüberblick über die Heilpädagogische Förderdiagnostik als Status- und Prozessdiagnostik innerhalb der heilpädagogischen Förderung (auf der Grundlage von **Kobi**)
- Heilpädagogische Förderdiagnostik (HPFD) in der Heilpädagogischen Förderung (HPF) und Vorschläge zur Umsetzung im Modul 4, Teil I

#### **Erläuterungen zu den Begriffen Heilpädagogische Förderung (HPF) und Heilpädagogische Fördereinheit (HPFE) im neuen Lehrplan**

Bei der bisherigen Verwendung des Begriffes Heilpädagogische Übungsbehandlung ging nicht eindeutig hervor, ob mit HPÜ der gesamte Förderprozess oder die einzelne Fördereinheit gemeint war. Deshalb haben die Mitglieder der Lehrplankommission die Begriffe Heilpädagogische Förderung (HPF) bzw. Heilpädagogische Fördereinheit (HPFE) statt Heilpädagogische Übungsbehandlung (HPÜ) gewählt, da sowohl in der Fachliteratur als auch in der Praxis (bes. in der Frühförderung) von der „Förderung“ der gesamten Persönlichkeit ausgegangen wird, während bei Therapien/Behandlungen dies i. d. R. auf einen Bereich des Patienten defizitorientiert geschieht.

Therapien (Leistungen der medizinischen Rehabilitation) basieren auf einer rezeptpflichtigen Verordnung durch den Arzt, und diese werden durch den Therapeuten über die jeweilige Krankenkasse des Patienten abgerechnet, während die Genehmigung und Kostenübernahme der Heilpädagogischen Förderung durch das Sozial- bzw. Jugendamt erfolgen.

Diese Unterschiede sind in der Ausbildung hervorzuheben, um begrifflichen und inhaltlichen Unkorrektheiten entgegenzuwirken, da mitunter von Patienten statt Klienten oder Therapie/Behandlung statt Förderung bzw. Therapeuten statt Heilpädagogen gesprochen wird.

## **Gesetzliche Grundlage der Heilpädagogischen Förderung (HPF)**

Die Hinweise und kurzen Erläuterungen zu entsprechenden gesetzlichen Grundlagen erscheinen im Zusammenhang mit dem Vorstellen regional bezogener, unterschiedlicher „Anträge zur Gewährung von Eingliederungshilfe“ sinnvoll, da in diesen Anträgen jeweils Bezug auf die zutreffenden §§ genommen wird.

- Die HPF erfolgt auf der Grundlage einer Verordnung durch den Kinder- bzw. Amtsarzt oder Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) entsprechend:

### **§ 4 SGB IX Leistungen zur Teilhabe**

### **§ 30 SGB IX Früherkennung und Frühförderung**

### **§ 55 SGB IX Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

### **§ 56 SGB IX Heilpädagogische Leistungen**

### **§§ 53 – 58, 60 SGB XII Aussagen zu Leistungsberechtigten, Leistungen zur Hilfe, Pflege und Unterbringung, schulischen und beruflichen Rehabilitation sowie zur Erstellung des Gesamtplanes durch die Sozialträger *[inhaltlich zusammengefasst]***

- Auf der Grundlage der ärztlichen Verordnung oder auf Anraten pädagogischer Fachkräfte stellen die Eltern beim Träger der Sozialhilfe (Sozialamt) einen Antrag auf Gewährung von Eingliederungshilfe. Die Antragsformulare sind bei den Sozial- und Jugendämtern der jeweiligen Stadt bzw. beim Landkreis unterschiedlich gestaltet. Sie sind im Internet auf der Homepage für die jeweilige Stadt oder den Landkreis unter „Sozialamt“ oder einer ähnlichen Rubrik zu finden.

Von der unterrichtenden Lehrkraft sollten Anträge für Komplexleistungen (SGB IX, § 55, Abs. 2, Nr. 2 und § 56) beispielhaft vorgestellt werden, da sie i. d. R. umfangreich gestaltet sind. Die Anträge für Komplexleistungen enthalten meist neben umfangreichen personenbezogenen anamnestischen Daten für den Leistungsempfänger ärztliche bzw. therapeutische Gutachten, Einschätzungen zu Entwicklungsbereichen ohne und mit Förderbedarf durch die zu betreuende KITA, Erklärungen zur Entbindung von der Schweigepflicht und evtl. einen Antrag auf Weiterbewilligung der Eingliederungshilfe. Dadurch wird dem Fachschüler die Notwendigkeit für eigene heilpädagogische diagnostische Erhebungen in seiner künftigen Tätigkeit als HP bzw. für das Berufspraktikum im 3. Ausbildungsjahr vermittelt. Hierbei ergeben sich auch gute Ansatzpunkte, um auf die Verknüpfungen der Inhalte der verschiedenen Ausbildungsmodule hinzuweisen und diese entsprechend klientenbezogen anzuwenden.

In die Präsentation der regional unterschiedlichen gestalteten Anträge sollten die Fachschüler aktiv mit einbezogen werden.

- Die HPF erfolgt auf der Grundlage eines Maßnahmeplanes/Gesamtplanes (oft als Komplexleistungen), den der Träger der Sozialhilfe in interdisziplinärer Zusammenarbeit erstellt. **ThürKitaG § 7**
- Für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden Anträge auf Eingliederungshilfe beim Jugendamt gestellt, auf der Grundlage

### **§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

- Die Bewilligung der Eingliederungshilfe wird i. d. R. zunächst für ½ oder 1 Jahr mit konkretem Budget für die bewilligten Fördereinheiten und festgelegtem zeitlichen Förderumfang pro Monat bzw. Woche ausgestellt. Die Genehmigung des Umfangs und die Zusage der Kostenübernahme erfolgt durch das Sozial- bzw. Jugendamt entsprechend des „Antrages auf Gewährung von Eingliederungshilfe“ nach SGB XII, Kap. 6, § 30 - 60 in Verb. mit SGB IX, § 55 Abs. 2 Nr. 2 - 4, § 56 bzw. SGB VIII § 35a.

↴ Die Heilpädagogische Förderung (HPF) setzt eine personenorientierte Feststellung des individuellen Förderbedarfs des Klienten voraus.

### Kurze Charakterisierung der Heilpädagogischen Förderdiagnostik (HPFD)

„Die diagnostische Einschätzung ist die Grundlage einer verantwortungsvollen Förderung und der Zugangsweg zu der subjektiven Erlebniswelt des Kindes [Jugendlichen/ Erwachsenen] im Sinne der heilpädagogischen Maxime von Moor, ‚Erst verstehen, dann erziehen‘. Zu aller erst geht es darum, das Kind in seinem „So-geworden-Sein“ verstehen zu wollen und aus dieser verstehenden Haltung heraus die gesamte Lebenssituation des Kindes zu betrachten.“ (v. Oy/Sagi 2011, S. 91)

Im Gegensatz zur medizinischen Diagnostik, die eine Eingangsdiagnose erstellt, ist ... „die heilpädagogische Diagnostik immer auf Förderung ausgerichtet und kann daher als **Förderdiagnostik (FD)** bezeichnet werden. Sie ist nicht auf die Defizite hin ausgerichtet. Die offenen Möglichkeiten des Kindes und seines Umfeldes stehen im Vordergrund“ (a. o. O. S. 91).

Die **FD** ist als ganzheitliche **Status- und Prozessdiagnostik** zu verstehen, da sie sich sowohl auf die gesamte Persönlichkeit des Klienten mit all seinen individuellen Ausprägungen als auch immer auf den gesamten heilpädagogischen Förderprozess bezieht (vgl. a. o. O. S. 91).

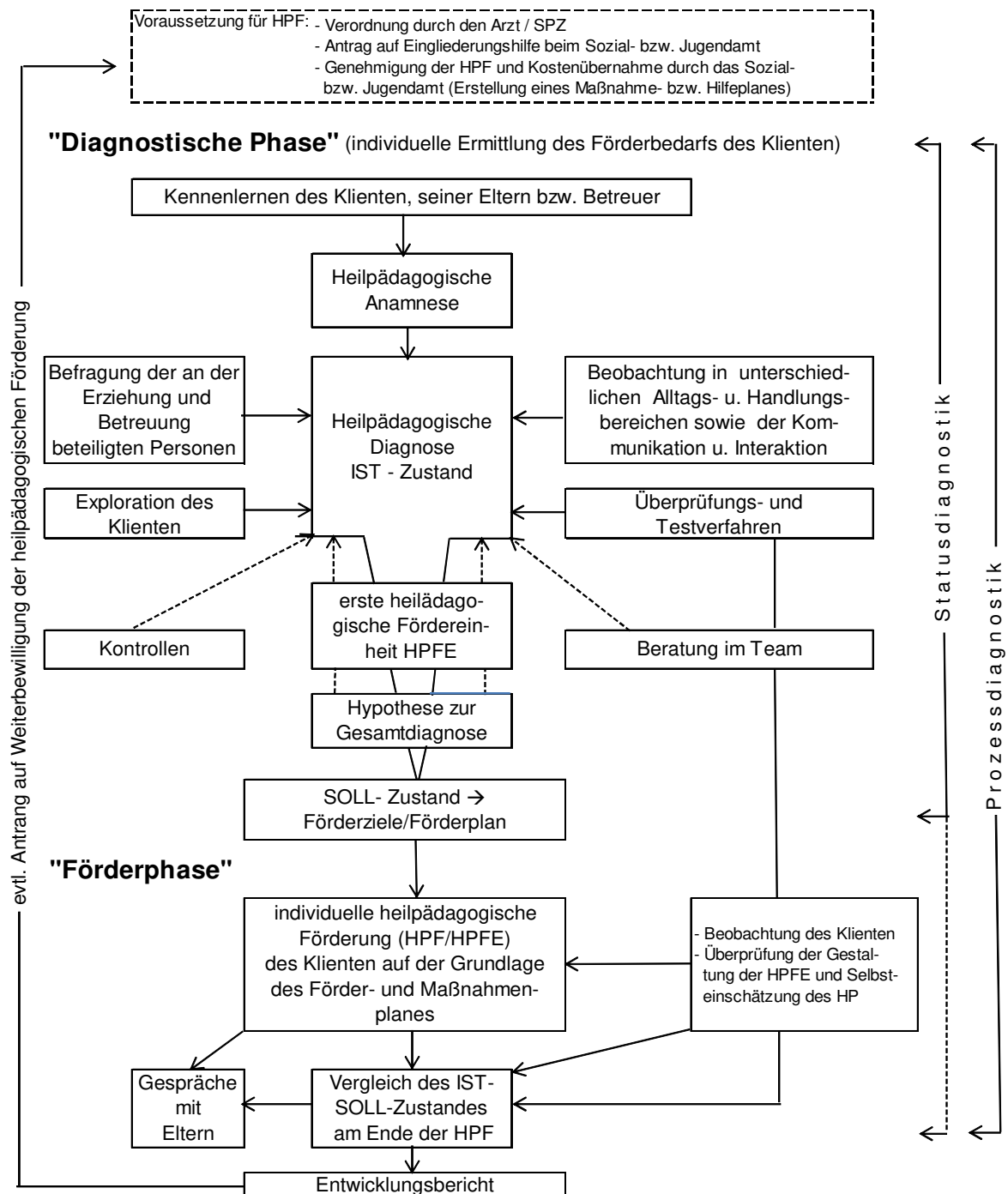
#### Ziele und Aufgaben der Heilpädagogischen Förderdiagnostik bestehen im

- Erkennen von Handlungsansätzen (Heilpädagogische Diagnose), d. h. das Erkennen und Verstehen des „So-geworden-Sein“ des Klienten mit seiner individuellen Biografie, der Komplexität all seiner Entwicklungs- und Lebensbereiche, seines Verhaltens im Kontext sowie die Bedeutung, welchen Sinn das jeweilige Verhalten für den Klienten hat. Dies erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und Methodenvielfalt, die „... eine diagnostische Informationssammlung und die einzelfallbezogene Auswertung dieser Daten ermöglicht.“ (vgl. Gröschke 1997, S. 274 ff. In: v. Oy/Sagi 2011, S. 93)
- Planen notwendiger Förderansätze, Förderziele (Richt- und Nahziele)
- begleitenden und reflektierenden Handeln in jeder Heilpädagogischen Fördereinheit (HPFE)
- abschließenden diagnostischen Überprüfen der Entwicklung des Klienten anhand der Förderziele sowie Fixierung der Ergebnisse der Heilpädagogischen Förderung in Form eines Entwicklungsberichtes

Um die Heilpädagogische Förderdiagnostik in ihrer Komplexität für die Fachschüler auch vor dem Hintergrundwissen der voran dargestellten Inhalte zu verdeutlichen, wurde der Versuch unternommen (**auf der Grundlage von Kobi** In: Schramm 1988, S. 55) diese in der Heilpädagogischen Förderung als ganzheitliche Status- und Prozessdiagnostik darzustellen. Die nachstehende Übersicht könnte als allgemeiner Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für die sich daran anschließende detaillierte didaktisch-methodische Erarbeitung der einzelnen Aspekte der Heilpädagogischen Förderdiagnostik innerhalb der Heilpädagogischen Förderung genutzt werden.



## Die Heilpädagogische Förderdiagnostik (HFD) als Status- und Prozessdiagnostik innerhalb der Heilpädagogischen Förderung (HPF)



**Heilpädagogische Förderdiagnostik  
(HPFD) in der Heilpädagogischen Förderung (HPF) und Vorschläge zur Umsetzung im  
Modul 4, Teil I**

Anlehnend an die vorangestellten theoretischen Aspekte nach Kobi ergibt sich für die Umsetzung in der heilpädagogischen Praxis ebenso die Notwendigkeit, mit den Fachschülern ein Handlungsmodell zu entwickeln, anhand dessen sie eine Orientierung für ihr eigenes Tun erfahren und welches sie als didaktisch-methodisches Instrumentarium einsetzen können.

Abgesehen von den inhaltlich empfohlenen Schwerpunkten zur Heilpädagogischen Förderdiagnostik sind die Auswahl und der Einsatz von diversen Materialien wie Beobachtungs-/Entwicklungsbögen, Tests und Überprüfungsverfahren sowie Unterlagen hinsichtlich der Förder- oder Hilfeplanung stets individuell und entsprechend den Handlungs- und Arbeitsfeldern der Fachschüler auszurichten. Dies obliegt dem unterrichtenden Lehrer in Kommunikation mit den Fachschülern. Zu berücksichtigen ist, dass mitunter Tests und Überprüfungsverfahren (projektive Testverfahren) auch im heilpädagogischen Handlungsfeld erscheinen können, welche ausschließlich von Psychologen oder Personen mit entsprechender Qualifikation durchgeführt und diagnostisch ausgewertet werden dürfen.

Nachfolgend sind didaktisch-methodische Anregungen zur Umsetzung der diagnostischen Aspekte in einer Übersicht mit differenzierten Vorschlägen zu finden.

## Heilpädagogische Förderdiagnostik (HPFD) in der Heilpädagogischen Förderung (HPF)

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">D<br/>I<br/>A<br/>G<br/>N<br/>O<br/>S<br/>T<br/>I<br/>S<br/>C<br/>H<br/>E<br/><br/>P<br/>H<br/>A<br/>S<br/>E</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Anamnese</b><br/>in Form der Fremdanamnese</li> <li><b>2. Beobachtung</b><br/>auf dieser Grundlage erfolgt eine Beschreibung – Beobachtung des freien und gelenkten Spielverhaltens, des Lern- und Arbeitsverhaltens unter bestimmten Aspekten (z. B. Motorik, Sprache, visuelle und auditive Wahrnehmung, Spielverhalten, emotionales und soziales Verhalten ...)</li> <li><b>3. Überprüfungsverfahren</b><br/>zur Ermittlung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Persönlichkeitseigenschaften an Hand von <b>Entwicklungsbögen, Tests</b> (z. B. Sensomotorisches Entwicklungsgitter von Kiphard/Sinnhuber, Mann-Zeichentest von Ziler (überarbeitet von Brosat/Töttemeyer 2001/02), Diagnostische Einschätzungsskalen zur Überprüfung der Schulfähigkeit von Barth, Entwicklungs- und Verhaltensprofil PEP-R für Menschen mit Autismus von Schopler/Reichler/Bashford/., Familie in Tieren, Motoriktest 4 – 6 Jahre, ...)</li> <li><b>4. Auswertung</b><br/>aller vorliegenden Daten und Unterlagen einschließlich <b>Explorationen</b> und <b>Befragungen</b> sowie <b>Feststellung des IST-Zustandes</b> (aktueller Entwicklungsstand des Klienten, dieser IST-Zustand sollte nach ca. 4 - 6 Wochen erhoben sein)</li> <li><b>5. Hypothesenbildung</b><br/>hypothetische Überlegung zur Gesamtdiagnose bzw. die Frage nach möglichen Ursachen für die Auffälligkeit, Beeinträchtigung oder Störung</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;">F<br/>Ö<br/>R<br/>D<br/>E<br/>R<br/>P<br/>H<br/>A<br/>S<br/>E</p>                                                | <p><i>(Noch in enger Verbindung zur diagnostischen Phase)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>6. Fixierung von Richt- und Nahzielen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richt- und Nahziele müssen sinnvoll, realistisch und erreichbar sein (sie werden im Verlauf der HPF dauernd überprüft, bei Bedarf ergänzt, geändert bzw. differenzierter gestaltet)</li> <li>- Aufstellung eines <b>Förderplanes</b></li> </ul> </li> <li><b>7. Reflexion der einzelnen HPFE innerhalb der HPF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung des Klienten während der HPFE, Umsetzung der Lernziele</li> <li>- kritische Einschätzung der eigenen Arbeit des Heilpädagogen</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>8. Gespräch mit den Eltern</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- im Interesse einer engen Zusammenarbeit</li> </ul> </li> <li><b>9. Auswertung der HPF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergleich des IST- und SOLL-Zustandes</li> <li>- Erstellung eines Entwicklungsberichtes</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Aspekte der diagnostischen Arbeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Möglichkeiten zur didaktisch-methodischen Umsetzung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Vorstellungsanlass</b><br/>Empfehlung/Überweisung Kinderarzt /SPZ o. a.,<br/>Verweis auf relevante Arbeitsfelder von Ärzten und Therapeuten, die vorrangig Kinder und Jugendliche betreuen</p> <p><b>Gespräche</b><br/>Eltern/Bezugspersonen mit dem Klienten selbst<br/>Gespräche mit anderen an der Entwicklungsförderung beteiligten Personen /Professionen</p> <p><b>Beantragung entsprechender Unterstützung</b></p> | <p>Vermittlung von relevanten Inhalten<br/>Erfahrungen aus eigenen Arbeitsfeldern</p> <p>Gesprächsführung in Kommunikation/ Rollenspiele (vgl. Modul 3, Teil II und Modul 13)</p> <p>Vorstellung und Erläuterungen von entsprechenden Formularen/Vordrucken der kommunalen Sozialträger (vgl. Hinweis unter „Gesetzliche Grundlagen der HPF“)</p>                                                                                             |
| <p><b>Anamnese/einschließlich Befunde</b><br/>hinsichtlich der Entwicklungsgeschichte des Klienten bis zum Zeitpunkt der Vorstellung in allen Entwicklungsbereichen, besonders unter Beachtung seines sozialen Umfeldes, dabei auch Aufnahme von medizinischen, psychologischen und therapeutischen Befunden</p>                                                                                                                | <p>Erarbeiten der inhaltlichen Kriterien einer heilpädagogischen Anamnese</p> <p>Vorstellen verschiedener Anamnesebögen</p> <p>Vorstellen von Beispielen heilpädagogischen Anamnesen unter Berücksichtigung des Datenschutzes (Einsatz von Facharbeiten)</p> <p>Erstellen einer heilpädagogischen Anamnese von einem selbst gewählten Klienten aus dem eigenen Arbeitsfeld<br/><b>Beleg im 1. Ausbildungsjahr (als Leistungsnachweis)</b></p> |
| <p><b>Beobachtung des Klienten</b></p> <p>Heilpädagogische Beobachtung</p> <p>Beobachtung des Klienten nach verschiedenen Beobachtungskriterien</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Begriff, Inhalt und Methode der heilpädagogischen Beobachtung in der HPF</p> <p>Beobachtungskriterien nach Oy/Sagi: LB der Heilpädagogischen Übungsbehandlung</p> <p>Vorstellen individueller Beobachtungsbögen, auch von den Fachschülern aus eigener Praxis<br/>Übungen zur Beobachtung von Klienten mit Entwicklungsbesonderheiten im Unterricht, Einsatz von Filmsequenzen/Fallbeispielen</p>                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Überprüfungsverfahren/Standardisierte Testverfahren</b></p> <p>Vorstellen individueller Verfahren (auch aus unterschiedlichen Modulbereichen) für Klienten aus verschiedenen Arbeitsfeldern</p> <p>wie z. B.<br/>Frühförderung, Elementar- und Vorschulerziehung nach SGB IX, Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII, Schulbegleitende Maßnahmen in Regel- und Förderschulen, Erwachsenenbildung und Wohnformen nach SGB XII</p> | <p>Verweis auf geeignete Auswahl von entsprechenden Überprüfungsverfahren bzw. Tests unter Berücksichtigung des Lebens- bzw. Entwicklungsalters, der Bedürfnisse/Entwicklungsbesonderheiten des Klienten</p> <p>Vorstellung, Durchführung und Erprobung verschiedener Überprüfungsverfahren (gemäß Anweisung und Instruktion unter Verwendung der entsprechenden Fachliteratur) und deren Auswertung</p> <p>Frühkindliche Entwicklung/verschiedene Entwicklungsbereiche, z. B.:</p> <p>Sensomotorisches Entwicklungsgitter (SEG) von Kiphard und Sinnhuber für entwicklungsverzögerte Kinder von 0 bis 7½ Jahre</p> <p>Mann-Zeichen-Test (MZT) nach Hermann Ziler überarbeitet von Brosat/Tötemeyer 2001/02 für Kinder ab 3 bis 14 Jahren zur Überprüfung der Körperwahrnehmung, graphomotorischer Fähigkeiten und der visuellen Wahrnehmung</p> <p>Förderdiagnostik bei schwerstbehinderten Kindern von Haupt/Fröhlich, überarb. 2004<br/>Förderdiagnostik bei Kindern mit einem analogen Entwicklungsalter von maximal 1 Jahr verbunden mit Förderhinweisen</p> <p>Spiel/Sozial-emotionale Entwicklung, z. B.:<br/>„Schweinchen Schwarzfuß – Test“<br/>„Familie in Tieren“ (FIT) vgl. Modul 6.13 (projektive Testverfahren, sie dienen der Beobachtung des Klienten, vom HP darf keine Interpretation vorgenommen werden)</p> <p>Autismus<br/>Entwicklungs- und Verhaltensprofil<br/>PEP-R<br/>nach Schopler/Reichler/Bashford/Lansing/Marcus<br/>zur Förderdiagnostik bei Kindern mit Autismus oder Kindern mit ähnlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen/bezieht sich auf Kinder mit einem Entwicklungsalter bis zu 7 Jahren</p> <p>Gespräche zu anderen Verfahren, die in den Arbeitsfeldern der Fachschüler zum Einsatz kommen und deren evtl. Vorstellung durch den Fachschüler</p> <p>Erfragen individueller Bedarfe an weiteren Verfahren</p> <p>Durchführung und Dokumentation eines Überprüfungsverfahrens nach eigener Wahl</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>(möglichst vom gleichen Klienten, dessen Anamnese schon erstellt wurde) unter folgenden Gesichtspunkten:<br/>Einsatz unter welchem Aspekt/in welchen (Entwicklungs-) Bereichen, Zielgruppe/Alter, Anleitung (gem. Literaturhinweise bzw. Zugangsmöglichkeiten zum Verfahren), Durchführung, Auswertung (auch verbale) des Tests bzw. Überprüfungsverfahrens<br/><b>Beleg im 1. Ausbildungsjahr (als Leistungsnachweis)</b></p> |
| <p><b>Beschreiben des aktuellen Entwicklungsstandes</b><br/>Beschreibung in Anlehnung an die Beobachtungskriterien nach Oy/Sagi (Verweis auf Literatur und siehe oben „Beobachtung des Klienten“)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Vorstellen von Beispielen unter Berücksichtigung des Datenschutzes (Einsatz von Facharbeiten)</p> <p>Erstellen einer heilpädagogischen Beschreibung von einem selbst gewählten Klienten aus dem eigenen Arbeitsfeld (Bezug zu Anamnese und Überprüfungsverfahren)<br/><b>- Beleg im 1. Ausbildungsjahr (als Leistungsnachweis)</b></p>                                                                                         |
| <p><b>Erfassen der Gesamtdiagnose mit Hypothesenbildung</b><br/>Der Heilpädagoge übernimmt im Team bei einer vorläufigen Analyse der Gesamtsituation (Gesamtproblematik) („als Anwalt des Klienten“) einen wichtigen Beitrag – eine mehrdimensionale Betrachtung aller Informationen führt dazu, den Klienten und seine Bezugspersonen in einer Gesamt-Situations-Analyse zu sehen, d. h. zunächst dessen <b>IST-Zustand</b> zu erkennen und zu beschreiben.</p> <p>Daraus ergibt sich die Definition des <b>SOLL-Zustandes</b> – eine <b>Arbeitshypothese</b> – die sich an den realen Möglichkeiten des Klienten und seiner Familie/Bezugspersonen orientiert.</p> <p>Aus der <b>Hypothesenbildung</b>, den hypothetischen Überlegungen zur Gesamtdiagnose, formuliert der Heilpädagoge erste Richt- und Nahziele, die sinnvoll und erreichbar sind</p> | <p>Erläuterungen durch den Fachschullehrer</p> <p>Übungen zur Hypothesenbildung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Ableiten der Förderschwerpunkte</b><br/>Erfassen der Förderschwerpunkte anhand der diagnostischen Ergebnisse aus den vorangegangenen Prozessphasen – Gespräche mit Klienten/Eltern o.a.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Gesprächsrunden und Diskussionen unter verschiedenen Gesichtspunkten u.a. zu Förderschwerpunkten von Klienten aus eigenem Arbeitsfeld<br/>Rollenspiel – Diskussion aus Sicht von</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezugspersonen und professionellen Unterstützern                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eltern, Bezugspersonen und professionellen Unterstützern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Formulierung der Förderziele auf der Grundlage der Förderschwerpunkte in Zusammenarbeit mit Eltern und ev. Bezugspersonen</b><br>Förderziele sind die Basis für das heilpädagogische Handeln – Erarbeiten der fachlichen Ansätze von Förderzielen unter Berücksichtigung ihrer Differenzierung in Richtziele/Nahziele | Einsatz von Beispielen aus Fachliteratur und Facharbeiten – Studium in der schulinternen Bibliothek<br><br>Arbeit mit Fallbeispielen aus der Praxis – Übungen zur Aufstellung und Formulierung von individuellen Förderzielen, hierbei die Stärken/Entwicklungsbesonderheiten erfassen und einbinden (evtl. zu dem Klienten, der bereits in den 3 Leistungsnachweisen beschrieben wurde)<br>Übungen zur Formulierung von Richtzielen/Nahzielen in Vorbereitung auf das praktische Handeln im 3. Ausbildungsjahr |
| Aufstellen eines <b>Förderplanes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fixierung der Förderziele im Förderplan<br>Vorstellen von Förderplänen aus den Arbeitsfeldern der Fachschüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fortführung der Heilpädagogischen Förderdiagnostik in den HPFE</b><br>Beobachtung in den HPFE hinsichtlich der Umsetzung der Lernziele durch den Klienten sowie seines individuellen Verhaltens während der Förderung<br>Kritische Reflexion der eigenen Arbeit des HP                                                | Erläuterung an Hand ausgewählter Beispiele aus Facharbeiten (Datenschutz beachten), um den Prozesscharakter der Heilpädagogischen Förderdiagnostik während der HPF zu belegen<br>Hinweis auf ausführliche Vorstellung der HPF/HPFE im 2. Ausbildungsjahr (Modul 4, Teil II)<br><br>Exkursion in Einrichtungen der heilpädagogischen Frühförderung bzw. Einrichtungen mit heilpädagogischen / integrativen/inklusiven Konzepten aus den verschiedenen Arbeitsfeldern                                             |
| <b>Interdisziplinäre Zusammenarbeit</b><br>Gespräche und Austausch über Ergebnisse der erfolgten Heilpädagogischen Förderung (HPF) und evtl. Notwendigkeit über deren Weiterführung sowie der sich daraus ergebenden Beantragung auf Weiterbewilligung bei den kommunalen Sozialträgern                                  | Erfahrungen aus eigenen Arbeitsfeldern<br><br>Bezug zu „Gesetzliche Grundlagen in der HPF“ (siehe oben „Formulare zum Antrag auf Eingliederungshilfe“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auswertung der HPF</b><br>Vergleich des IST-/SOLL-Zustandes<br>Dokumentation der Ergebnisse in einem Entwicklungsbericht                                                                                                                                                                                              | Vorstellung eines möglichen Modells für einen Entwicklungsbericht<br>Beispiele zu Entwicklungsberichten aus der heilpädagogischen Praxis<br>Hinweise auf das Praktikum und Anfertigung der Facharbeit (3. Ausbildungsjahr)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Renate Meisel-Becker

Antje Schmalisch

## Teilmodul 2: Grundlagen der Diagnostik und Förderung von Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten

Wie bereits im Teil I erwähnt, orientieren sich diese Anregungen an den zu erwerbenden Kompetenzen der Fachschüler. Auch im Teil II werden Empfehlungen und Aspekte angesprochen, die in dieser Form nicht bindend, sondern beispielhaft sind und jedem unterrichtenden Fachschullehrer obliegt es, eigene individuelle Schwerpunkte zu setzen.

Nochmals ist in diesem Teil das Augenmerk auf die Erläuterungen zu den Begriffen **Heilpädagogische Förderung (HPF)** und **Heilpädagogische Fördereinheit (HPFE)** zu richten.

Bei der bisherigen Verwendung des Begriffes Heilpädagogische Übungsbehandlung ging nicht eindeutig hervor, ob mit HPÜ der gesamte Förderprozess oder die einzelne Fördereinheit gemeint war. Deshalb haben die Mitglieder der Lehrplankommission die Begriffe Heilpädagogische Förderung (HPF) bzw. Heilpädagogische Fördereinheit (HPFE) statt Heilpädagogische Übungsbehandlung (HPÜ) gewählt, da sowohl in der Fachliteratur als auch in der Praxis (besonders in der Frühförderung) von der „Förderung“ der gesamten Persönlichkeit ausgegangen wird, während bei Therapien/Behandlungen dies i. d. R. auf einen Bereich des Patienten gerichtet ist. Weiterführende Aussagen zu diesem Aspekt sind in Teil I nachzulesen.

Inhaltlich erfasst der Teil II zu Kernmodul 4 folgende Schwerpunkte:

- **Heilpädagogische Förderung (HPF) als Förderprozess**
- **Heilpädagogische Förderung (HPFE – Heilpädagogische Fördereinheit)**
- **Weitere heilpädagogische Methoden und ausgewählte Handlungsansätze**

### ***Heilpädagogische Förderung (HPF) als Förderprozess***

Auf der Grundlage theoretischer Erhebungen nach C. M. von Oy und A. Sagi („Lehrbuch der heilpädagogischen Übungsbehandlung“, 14. Auflage, Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg – Edition S, 2011) wurde die **Heilpädagogische Übungsbehandlung (HPÜ) als Methode der Heilpädagogik** differenziert und ausführlich beschrieben. Inhaltlich kann dies auch für die Begrifflichkeit **Heilpädagogische Förderung (HPF)** übernommen und wie in den folgenden Aussagen vermittelt werden:

- **HPF** – Methode der systematischen Hilfe für entwicklungsgestörte Menschen und Menschen mit einer geistigen Behinderung, vor allem für Kinder und Jugendliche
- bietet ein **ausgewogenes Angebot** von Fördereinheiten unter Berücksichtigung der individuellen Möglichkeiten der Klienten
- im Spiel und durch Spiele werden **neue Kenntnisse, Fähigkeiten und sinnvolle Verhaltensweisen in Einzel- und Gruppensituationen** geweckt, entwickelt und gefestigt
- **HPF** ist grundsätzlich auf die **Gesamtförderung**, d.h. auf die **Förderung der sensorischen, motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten** ausgerichtet
- Teilleistungsschwächen unterschiedlicher Ursachen sollen durch ein vielfältiges Angebot an **Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten in der visuellen, auditiven sowie taktilen Erfassung und Differenzierung der Umwelt** ausgeglichen oder gemildert werden
- **Zusammenarbeit mit den Eltern** ist integrierter Bestandteil der **HPF**



- Förderung ist ein länger **andauernder Prozess** (meist abhängig von einer Bewilligung seitens der Leistungsträger)
- d. h. **HPF** ist sowohl **Methode**, in der ebenso andere heilpädagogische Methoden wie Basale Stimulation und Kommunikation, Spiel oder Sensorische Integrationstherapie u.a. zum Einsatz kommen können, als auch ein komplexer **Prozess**

Ergänzend zu den Fördermöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen im und durch das Spiel sind für junge Heranwachsende und Erwachsene individuelle Arbeits- und Lebenssituationen einzubinden. Des Weiteren ergibt sich zur Zusammenarbeit mit den Eltern eine Erweiterung der Zusammenarbeit in Richtung Kooperation mit Wohn- sowie Fördereinrichtungen und den beauftragten Bezugspersonen/Kontaktbetreuern für die Klienten.

Im Teil I wurde bereits mit der Heilpädagogischen Förderdiagnostik (HPFD) in der Heilpädagogischen Förderung (HPF) Grundlegendes zum Förderprozess aufgeführt, welches die wesentlichen Aspekte für diesen Punkt vervollständigt.

### ***Heilpädagogische Förderung (HPFE – Heilpädagogische Fördereinheit)***

Mit der Heilpädagogischen Förderung wird das konkrete heilpädagogische Handeln in systematisierter Form aufgezeigt. Die Förderung baut sich durch aufeinander bezogene bzw. miteinander verbundene Heilpädagogische Fördereinheiten (HPFE) auf. Jede einzelne ist ein wichtiger Bestandteil in diesem gesamten Prozess. Im Zentrum des Geschehens stehen für den Heilpädagogen der Klient und die Begegnung mit ihm. Mit jeder Begegnung gewinnt der gesamte Förderprozess an Tiefe und differenzierteren Entwicklungschancen des Klienten.

Hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung der HPF/HPFE sind vom Heilpädagogen individuelle **Vorüberlegungen zum heilpädagogischen Handeln (Raum-Material-Personen-Orientierung)** zu treffen:

#### **Raum – Material – Person – Orientierung**

- formale und inhaltliche Überlegungen orientieren sich am Klient und seiner Familie bzw. an seinen Bezugspersonen und den realen Möglichkeiten des Heilpädagogen, der die HPF durchführt
- Fragen stellen sich u. a.: Wo und wie oft sollten HPFE durchgeführt werden? In der Anfangsphase in Anwesenheit einer Bezugsperson oder ohne? Begegnung im häuslichen und/oder außerhäuslichen Bereich?
- Wünsche und Vorstellungen der Eltern (Bezugspersonen) bzgl. inhaltlicher Gestaltung der HPFE werden mit ersten Richt- und Nahzielen verglichen und in individuell erarbeiteten Förderplan übernommen
- erste Begegnung in der HPFE wird vom Heilpädagogen geplant und vorbereitet – eine erste heilpädagogische Handlungsorientierung berücksichtigt die Kontaktaufnahme in der Anfangsphase, eine erste Raum-, Material- und Personenorientierung
- heilpädagogische Beziehungsgestaltung zwischen Klient und Heilpädagoge muss auf Empathie, „Weit-Sehen“ (nicht nur den Augenblick sehen, sondern das Ziel anstreben), unverfälschter, echter Selbstdarstellung (Authentizität – Einschätzbarkeit für Klient) und einer gewissen Distanz (Sachlichkeit) basieren = im Sinne des professionellen Arbeitens

- Heilpädagoge muss Widersprüche zwischen Theorie und Praxis für sich erkennen und damit umgehen können
- Heilpädagoge muss emotional stabil sein
- Heilpädagoge muss zuverlässig sein (Konsequenz zeigen/ergibt Berechenbarkeit, Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit/Vermeidung von Enttäuschung, Zeit/ohne Störung mit Klienten nutzen, Regeln/ die ich aufstelle – muss ich ein- und aushalten können)

Die HPFE als einzelne Einheit erfordert vom Fachschüler Kenntnisse über Planung, Durchführung und Reflexion einer heilpädagogischen Fördereinheit (HPFE):

- **Förderplan** (entsprechend der Förderziele = Richt- und Nahziele) dient als Grundlage für den Förderprozess und einzelne HPFE
- **Thema** der HPFE wird abgeleitet aus der aktuellen Situationsanalyse (Themen alters- und entwicklungsentsprechend orientieren sich u.a. an Jahreszeiten, Festen, Projekten der Einrichtung, Interessen des Klienten, Umwelt, aktuelle Ereignisse)
- Formulierung und Auswahl von **Lern- oder Arbeitszielen** für die einzelnen HPFE (in der Förderung und Begleitung von erwachsenen Klienten kann mitunter für ein besseres Verständnis des Umfeldes von Arbeitszielen gesprochen werden)
- **Planung** unter methodischen, inhaltlichen und zeitlichen Aspekten sowie Beachtung der aktuellen Situation des Klienten (Inhalte leiten sich aus Thema ab, Anfangs- und Abschlussritual, Wechsel von Anspannung und Entspannung)
- **Vorbereitung** für einen reibungslosen Ablauf (Räumlichkeit, konstante Zeiten, Materialien, Absprachen im Team, Berücksichtigung von Abläufen)
- **Durchführung** (entsprechend einer Planung, Berücksichtigung individueller Besonderheiten aus Tagesgeschehen heraus)
- **Reflexion** (Angemessenheit der Lern-/Arbeitsziele und Methoden, Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen der Klienten, Materialauswahl, Auswertung der Beobachtungen während der HPFE, kritische Reflexion der eigenen heilpädagogischen Arbeit, Begründung der Veränderung im Ablauf gegenüber der Planung)
- dem folgt die komplexe **Auswertung des Prozesses** (siehe Teil I u.a. in einem Entwicklungsbericht)

Zur praxisnahen Vermittlung sind Übungen unter oben aufgeführten Aspekten mit autorisierten Videosequenzen hilfreich. Zudem erproben sich die Fachschüler in der Formulierung von Zielen im Unterrichtsgespräch, erfahren sich im Gedankenaustausch und reflektieren (mitunter bereits das eigene Handeln) unter verschiedenen Gesichtspunkten. Exkursionen bzw. Unterrichtsgänge in entsprechende Einrichtungen (Frühförderung, Integrative Kindereinrichtungen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung) vertiefen den Einblick in heilpädagogische Arbeitsfelder und das praktische Handeln in der Förderung.

Zur Planung und Dokumentation der HPFE sowie in Vorbereitung auf das eigene heilpädagogische Arbeiten entwerfen die Fachschüler anlehnend an bedeutsame Aspekte (u.a. Klient, Förderzeitraum, Ziele, Thema, Inhalt, Methodische Umsetzung, Material und Raum, Reflexion) ein Format bzw. eine Vorlage, mit der sie sich einen Handlungs- und Orientierungsrahmen für ihr Tun schaffen (siehe Modul 18).

Unter Einbindung der theoretischen Kenntnisse erfüllt u. a. ein solcher Auftrag die Anforderungen eines Leistungsnachweises.

### **Weitere heilpädagogische Methoden und ausgewählte Handlungsansätze**

Die Fachschüler erfahren den Unterschied von heilpädagogischen Methoden und ausgewählten Handlungsansätzen aus anderen pädagogisch-therapeutischen Bereichen, auch hinsichtlich deren Einbindung in die heilpädagogische Arbeit.

Neben der Heilpädagogischen Anamnese, Heilpädagogischen Beobachtung, Heilpädagogischen Förderung zählen weitere Methoden zu denen der Heilpädagogik wie die Basale Stimulation und Kommunikation besonders für Kinder mit einer Mehrfach-behinderung, das Heilpädagogische Spiel, Bewegungserziehung, Musiktherapie, Rhythmik, Kunsttherapie und die Sensorische Integrationstherapie/SI (vgl. auch Modul 13 - 16).

Ebenso bedeutsam ist der Blick auf ausgewählte Ansätze aus anderen pädagogisch-therapeutischen Bereichen, die unter differenzierter Betrachtung hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten bzw. Grenzen in die heilpädagogische Arbeit integriert werden können (Wahrnehmungsförderung auf der Grundlage der SI-Therapie, Indische Babymassage/Leboyer, Konduktive Frühförderung/Petö, Heilpädagogisches Reiten, Heilpädagogischer Tanz, Neurophysiologische Behandlungsansätze/Bobath & Vojta besonders bei neurologischer und cerebraler Bewegungsstörung, TEACCH-Ansatz als pädagogisches Konzept nach A. Häußler für Menschen mit Autismus, Konzept „Integrative Validation“ nach Richard für ältere Menschen mit Demenz).

Sowohl bei einigen heilpädagogischen Methoden wie auch bei diesen Handlungsansätzen ist vom Heilpädagogen im Vorfeld zu überprüfen, unter welchen Voraussetzungen der Einsatz erfolgen kann oder ob eine entsprechende Qualifizierung vorliegen muss.

Antje Schmalisch

## **Modul 5: „Sozial- und Qualitätsmanagement“**

### Das sozialrechtliche Dreieck

Den Leistungsanspruch der Leistungsberechtigten erfüllen die öffentlichen Sozialleistungsträger in der Regel nicht durch eigene Angebote sondern übertragen diese unterschiedlichen Anbietern.

Gegenüber den Leistungsberechtigten erfüllt der Sozial- oder Jugendhilfeträger seine Leistungsverpflichtungen dadurch, dass er den Leistungsberechtigten die Übernahme der Kosten der Inanspruchnahme einer heilpädagogischen Praxis, einer interdisziplinären Frühförderstelle usw. bewilligt.

Diese Konstellation wird allgemein als sozialrechtliches Dreieck bezeichnet.

In diesem sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis erfüllt der Sozial- bzw. Jugendhilfeträger seine Leistungsverpflichtung dadurch, dass er den Leistungsberechtigten von den Kosten freihält, die dieser für die Maßnahme an die heilpädagogische Praxis, interdisziplinäre Frühförderstelle usw. zu zahlen hätte.

Die Kostenerstattung ist unabhängig von den Vermögensverhältnissen des Klienten bzw. seiner Eltern. In diesen Fällen müssen keine Vermögensverhältnisse offengelegt werden.

Im sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis besteht kein Beschaffungsverhältnis zwischen einer freien heilpädagogischen Praxis und den öffentlichen Trägern.

Das heißt, dass die freie Praxis (zivilrechtlich) grundsätzlich allein gegenüber ihren Klienten/ den Leistungsberechtigten verpflichtet ist.

Außerdem ist es für Praxisanbieter, wenn sie als freie Unternehmer auf dem „Sozialmarkt“ eine Chance haben wollen, unerlässlich, mit dem Sozialhilfeträger eine Leistungs-, Vergütungs- und Prüfvereinbarung (§ 75 Abs.1 SGB XII) oder mit dem Jugendhilfeträger eine Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarung (§ 78b SGB VIII) abzuschließen. Hierzu muss eine ausführliche Leistungsbeschreibung der freien Praxis (einschließlich des Nachweises über die Qualifikationen des Personals) vorgelegt werden. Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen hat der Inhaber/die Inhaberin der freien Praxis einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung der Daraus folgt, dass den freien Praxen kein einklagbarer Anspruch gegen den Sozialleistungsträger auf Bezahlung der im Einzelfall erbrachten Leistungen zusteht.

Die freie Praxis kann die Bezahlung ihrer Leistung nur gegenüber dem Klienten geltend machen. Empfehlenswert ist daher stets der Abschluss eines schriftlichen Behandlungsvertrages (zwei Unterschriften) zwischen der heilpädagogischen Praxis und ihrem Klientel.

Soweit das Sozialamt/das Jugendamt der freien Praxis die Übernahme der Kosten im Einzelfall ausdrücklich zusichert, dann ist die Zusicherung nur dann rechtsverbindlich, wenn sie in Form eines schriftlichen Vertrages erteilt wird.

Verwaltung. Die Verwaltung hat nicht das Recht, diesem Anliegen mit einem Hinweis auf fehlenden Bedarf entgegenzutreten.

Zulässige Kriterien sind allein solche, welche die Qualität, den Umfang und den Preis der zu vereinbarenden Leistung betreffen.

Es ist darum wichtig, dass Inhaber freier Praxen wirtschaftlich solide und durch unterschiedliche Methoden und Angebote (auch für sogenannte Selbstzahler, durch Fortbildungstätigkeit oder Fachpublikationen) breit aufgestellt sind.

So sind sie weniger abhängig von der Bewilligungspraxis einer Gebietskörperschaft und wechselnden Bedarfen.

Quellen: SGB VIII, SGB XII, Fachverband Heilpädagogik (Hrsg.): Selbstständig als Heilpädagogin/Heilpädagoge Berlin 2014

Sybille Lenk

## **Sozial- und Qualitätsmanagement in der Heilpädagogik**

Kerngedanke der inhaltlichen Gestaltung und Schwerpunktsetzung ist die Bedeutung des Moduls für den Prozess der Gründung oder Leitung einer heilpädagogischen Praxis und die damit verbundene Selbstständigkeit des Absolventen.

Im Vorwort der Broschüre „Selbstständig als Heilpädagoge/Heilpädagogin“ des Berufsverbandes der Heilpädagogen wird festgestellt, dass eine Existenzgründung als Heilpädagoge bereits seit vielen Jahren nicht unüblich ist und auf der differenzierten Angebotsstruktur im Bereich der ambulanten Hilfen für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen basiert. Weiter wird festgestellt, dass der zunehmende Anteil der Teilzeitbeschäftigungen im sozialen Bereich auch das Tätigsein für mehrere Arbeitgeber erzwingt. Damit eröffnet sich aber auch der Raum für selbst initiierte Berufsperspektiven.

Unsere Empfehlung zur inhaltlichen Gestaltung des Moduls soll diesen Prozess unterstreichen.

Aufbauend auf den Modulen zum Qualitätsmanagement in der Fachschule der Bereiche der Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege könnte zunächst als Ausgangspunkt die Bedeutung der Qualität als Kriterium der pädagogischen Arbeit für die Zielebenen der Einrichtungen und der privaten Anbieter verdeutlicht werden. Ein Erfahrungsaustausch hinsichtlich bereits erfolgter Zertifizierungen oder des gerade durchlaufenden Prozesses unterstreicht die Bedeutung des Qualitätsmanagements und betont die Praxisrelevanz.

Eine Exkursion in eine entsprechende Einrichtung oder die Einbeziehung eines Experten aus der Praxis zum Thema der Existenzgründung unterstreicht die Bedeutung und die Veranschaulichung.

Ferner empfehlen wir Grundlagen der Unternehmensgründung im Gesamtkontext des Qualitätsmanagements zu stellen und in Gruppen eigenständig zu bearbeiten.

Dazu zählen:

- Grundlagen der Existenzgründung
- Unternehmensstrukturen
- gesetzliche Rahmenbedingungen
- Qualitätsmanagement in Leitungspositionen
- Kooperationen/Werbung

Es ist günstig, alle Inhalte in Form von „Bausteinen“ zusammentragen zu lassen und dann als Abschlussaufgabe in Form der Wirtschaftssimulation „zusammenzubauen“. Dies kann in Form von Präsentationen oder Gruppenbelegen erfolgen.

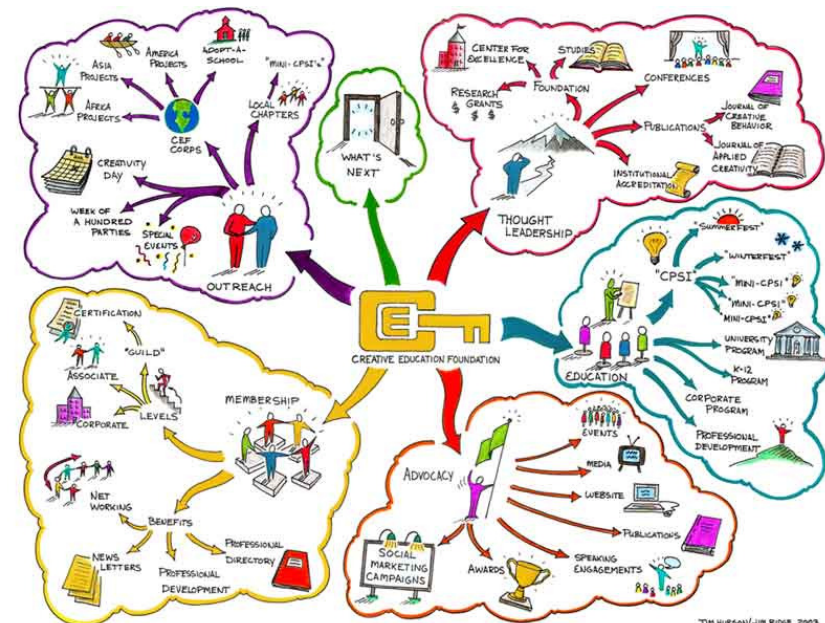
Ziel soll sein, nach vorgegebenen Parametern eventuell ein Handbuch zu erstellen. Simuliert werden kann hier z. B. eine Gründungsphase eines Unternehmens (Heilpädagogische Praxis) für 1 - 2 Jahre mit dem Ziel der Zertifizierung.

Alle weiteren Informationen können der nachfolgenden PowerPoint-Präsentation entnommen werden.

Christine Hockauf

## Modul 5

# Sozial- und Qualitätsmanagement in der Heilpädagogik



## Vorstellungen





1. Übersicht der Voraussetzungen aus HEP und E
2. Modulinhalte und Schwerpunkte HP in LP
  - a. Zeitpunkt
  - b. Inhalt
  - c. Leistungsnachweise / Abschluss
3. Schwerpunktsetzung der Inhalte
4. Abschluss / Wirtschaftssimulation
5. Weg in die Selbstständigkeit / Vorschlag der Inhalte





## Inhalte

## HEP

- Analyse institutioneller Bedingungen und Strukturen
- ethische Reflexion sich verändernder sozialer Realität
- Prinzip der Lernenden Organisation
- Übersicht über organisationsbezogene Kooperationsmodelle und Formen vernetzten Planens und Handelns
- Managementmodelle und -systeme im historischen Überblick
- Leitungstheorien und Führungsmodelle
- Schlüsselprozesse, Evaluationsverfahren, Personalentwicklungsinstrumente, Beschwerdemanagement, Öffentlichkeitsarbeit
- Grundlagen des Konflikt- und Case-Managements
- fachliche und organisatorische Qualitätsstandards auf der Grundlage sozialgesetzlicher Vorgaben
- beispielhafte Qualitätsmanagementsysteme
- spezifische Qualitätssicherung in der Pflege, in Kindertagesstätten und im Rahmen des persönlichen Budgets
- Dienstablaufplanung, Zeitmanagement, Informationssysteme und Informationsfluss
- EDV-gestützte Instrumente



### Inhalte

- soziale Arbeit als Dienstleistung
- Organisationsformen und Führungsmodelle
- Projektmanagement und Teamarbeit
- Schlüsselprozesse und Beschwerdemanagement
- Qualitätsstandards auf Basis der Sozialgesetzgebung in den Arbeitsfeldern
- exemplarische Qualitätsmanagementsysteme
- Konzeptionsentwicklung
- Informationssysteme und Öffentlichkeitsarbeit

E

Zeitpunkt



### 3. Ausbildungsjahr:

#### Kernmodule:

|      |                                                                                                           |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3  | Psychologisch-psychiatrische Grundlagen heilpädagogischen Handelns (Teil III)                             | 100 |
| 6.4  | Grundlagen der Diagnostik und Förderung von Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten (Teil III)            | 40  |
| 6.5  | Sozial- und Qualitätsmanagement in der Heilpädagogik                                                      | 40  |
| 6.12 | Menschen mit Besonderheiten im Bereich der geistigen Entwicklung inklusiv erziehen, fördern und begleiten | 60  |

#### **Zwei der folgenden noch nicht belegten Module müssen absolviert werden.**

|      |                                                      |     |
|------|------------------------------------------------------|-----|
| 6.13 | Heilpädagogische Spielbegleitung                     | 100 |
| 6.14 | Musik und musiktherapeutische Ansätze                | 100 |
| 6.15 | Motorische Entwicklungsförderung                     | 100 |
| 6.16 | Gestalterisch und bildnerisch - praktische Förderung | 100 |

#### Wahlpflichtmodule:

#### **Zwei von drei Modulen sind zu absolvieren.**

|        |                                                                                                                |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.17   | Heilpädagogisches Handeln in den Arbeitsfeldern                                                                |    |
| 6.17.1 | Heilpädagogen in Diensten und Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung                                           | 90 |
| 6.17.2 | Heilpädagogen in Diensten und Einrichtungen für Menschen mit drohenden oder manifestierten Behinderungen       | 90 |
| 6.17.3 | Heilpädagogen in schulvorbereitenden Einrichtungen, in Schulen, freien Praxen sowie Senioren- und Pflegeheimen | 90 |

#### Praxismodul:

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Berufspraktische Ausbildung | 320 |
|-----------------------------|-----|

Inhalt



Unternehmensbildung

Leitung

Qualitätssicherung

| Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wiederholung der allgemeinen Grundlagen des Sozial- und Qualitätsmanagements</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Unternehmensbildung und -führung durch<ul style="list-style-type: none"><li>• Fremdkapital</li><li>• Eigenkapital</li><li>• SGB bei Non-Profit-Organisation</li></ul></li><li>– rechtliche Rahmenbedingungen<ul style="list-style-type: none"><li>• Gewerbeordnung</li><li>• steuerliche Grundlagen</li><li>• HGB (relevante Auszüge)</li><li>• Unternehmensformen</li></ul></li><li>– Personalentwicklung<ul style="list-style-type: none"><li>• Führungsstile</li><li>• Personalgespräche und Beurteilungen</li><li>• Fortbildung/Weiterbildung konzeptionelle Planung</li></ul></li><li>– Qualitätsmanagement<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualitätsnormen</li><li>• Zertifizierungen</li><li>• Arbeit mit Klienten/Beschwerdewesen/Werbung</li></ul></li><li>– Feedbacksysteme<ul style="list-style-type: none"><li>• Transparenz nach innen und außen</li><li>• Formen der internen und externen Evaluierung, critical friends</li></ul></li><li>– Vereinsarbeit</li></ul> |
| <b>Erkundung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– betriebliche Situation/Verein</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 6.5 Sozial- und Qualitätsmanagement in der Heilpädagogik

### 6.5.1 Organisatorische Rahmenbedingungen

Leistungs-  
nachweise

Abschluss

|                                    |                                                           |   |                             |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| Lernbereich                        | Theoretische Ausbildung                                   | x | Berufspraktische Ausbildung |            |
| Modultyp                           | Kernmodul                                                 | x |                             |            |
|                                    | Wahlpflichtmodul                                          |   |                             |            |
|                                    | Projektmodul                                              |   |                             |            |
|                                    | Praxismodul                                               |   |                             |            |
|                                    |                                                           |   |                             |            |
| Gesamtstundenzahl                  | Unterrichtsstunden<br>davon fachmethodischer Unterricht   |   |                             | 40         |
| Arbeitsaufwand (workload)          | Unterrichtsstunden gesamt                                 |   |                             | 40         |
|                                    | Lehrveranstaltungen                                       |   |                             | 32         |
|                                    | Erkundungen                                               |   |                             | 1 (4 UStd) |
|                                    | Leistungsnachweise                                        |   |                             | 4          |
|                                    | Selbststudium                                             |   |                             | 10         |
|                                    | Zeitstunden                                               |   |                             | 40         |
|                                    |                                                           |   |                             |            |
| im Modul zu erbringende Leistungen | Vorleistungen                                             |   | 3 Leistungsnachweise        |            |
|                                    | Leistungsfeststellung                                     |   | Wirtschaftssimulation       |            |
|                                    |                                                           |   |                             |            |
| Zeitpunkt des Angebots             | 3. Ausbildungsjahr                                        |   |                             |            |
| Vernetzung mit anderen Modulen     | KM: Sozialpädagogik 7.20 und KM Heilerziehungspflege 7.10 |   |                             |            |

## Schwerpunktsetzung der Inhalte

Befähigung zur Unternehmensgründung

Erkennen der Notwendigkeit eines  
Qualitätsmanagements

Initiierung und Durchführung einer Zertifizierung

daher ...



Schwerpunktsetzung der Inhalte /  
Hauptinhalte

LN  
+  
Exkursion

Verständnisentwicklung

Verständnis von Qualität, Rahmenbedingungen,  
Aufgaben

Aufbau eines Qualitätsmanagements

Herzstück des QM „Kundenorientierung“

Aufbauorganisation / Ablauforganisation

DIN ISO 9000-er

QM Handbuch

Abschluss /  
Wirtschaftssimulation

Gruppeneinteilung



Verschieden Teilaufgaben als Schwerpunkte



Sozialrechtliches  
Dreieck  
(Verträge /  
Vereinbarungen)

Erste Schritte der  
Selbstständigkeit

Sicherung durch  
QM



Durch Einzelpräsentationen  
entsteht Gesamtbild



## Weg in die Selbstständigkeit

- Kalkulation des finanziellen Grundbedarfes  
(Investive und laufende Kosten) Was bleibt für mich?
- Räume / Büroorganisation / Scheinselbstständigkeit  
Anmeldung bei Berufsgenossenschaft /  
Rentenversicherungspflicht / Praxiseröffnung  
Werbung
- Zertifizierung der Praxis  
Ablauf / Voraussetzungen / Leitideen / QM Handbuch
- Steuerliche Aspekte
- Rechtliche Grundlagen u.a.  
Eingliederungshilfe SGB XII, SGB VIII,  
Frühförderung SGB IX  
Zuständigkeiten SGB XII, VIII, I, IX  
Antragserfordernisse .... etc.

Danke  
für Ihre Aufmerksamkeit



### **Modul 13: „Heilpädagogische Spielbegleitung“**

Im Spiel erlebt und präsentiert sich das Kind nach E. E. Kobi als Einheit von Person (Subjekt) und Gegenstand (Objekt). Das beobachtbare Verhalten und das subjektive Erleben fließen im Spiel als intermediärem Bereich – zwischen der äußeren Wirklichkeit und der inneren Realität – zusammen.

Insofern ist das Spiel einerseits Medium der Selbstdarstellung und bietet andererseits die Möglichkeit zur Verarbeitung von Erlebnissen.

Das Spielgeschehen wird vom Kind immer ganzheitlich gestaltet. Es prägt in seiner räumlichen und zeitlichen Dimension die Kindheit und schafft somit wichtige Erfahrungen für die Gestaltung des eigenen Lebensraumes.

Die Aufgabe der Heilpädagogin/des Heilpädagogen besteht unter anderem darin, dem Kind einen Spiel – Raum im Wortsinn, einen individuell ausgestalteten Rahmen im Sinn einer äußeren Haltgebung zu eröffnen. Dieser soll Orientierung geben, Sicherheit verleihen und somit entwicklungsförderliche Perspektiven eröffnen.

Einen wichtigen Zugang zu dieser lebendigen Vielfalt im Spiel stellt die Spielbeobachtung dar. Diese ermöglicht es prozessbegleitend Aufschluss über die Spielbedürfnisse zu erhalten, Zielstellungen abzuleiten und in die Planung von Fördereinheiten einfließen zu lassen.

So könnte man z. B. aus einer Rollenspielszene Schlussfolgerungen über die sensorische Dimension (Körperwahrnehmung, Bewegungsplanung), die kognitive Dimension (Symbolfähigkeit, Perspektivübernahme, magisches Denken), die sozial- emotionale Dimension (Kontaktverhalten, Empathiefähigkeit, exter- und internalisiertes Verhalten, Gefühle wahrnehmen, ausdrücken und regulieren) sowie die sprachlich – kommunikative Dimension (non – verbale Mitteilungsmöglichkeiten,

Sender – Empfänger Interaktionen) ableiten (vgl. Schroer, S. 9)

Des Weiteren lassen sich gute Aufschlüsse darüber gewinnen, wie sich das Kind selbst erlebt und welche Kompetenzen es bereits entwickeln konnte.

Das kann man gut am Beispiel der Sprachentwicklung und des Symbolverständnisses von den Fachschülern üben lassen.

Besonders gut eignet sich hier das Arbeiten mit den Materialien des Scenotestes nach Gerhild von Staabs.

Günstigerweise beginnt man im Unterricht mit einer gründlichen Einführung des standardisierten Verfahrens und einer aktenkundig zu machenden Belehrung, unter welchen Voraussetzungen dieses von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen angewendet werden darf.

Im Anschluss daran bittet man, einen Fachschüler/eine Fachschülerin mit dem Material eine Spielszene zu bauen. Alle anderen Fachschüler notieren jeder für sich, was sie konkret beobachten.

Im Anschluss daran liest jeder Fachschüler/jede Fachschülerin seine Notizen unkommentiert vor. In der Regel stimmen einige Beobachtungen überein und ein großer Teil der Beobachtungen divergiert.

Das führt eindrucksvoll zu der Erkenntnis, dass Beobachtung grundsätzlich selektiv ist, durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst wird und somit permanent geübt werden muss. Zu Beginn der folgenden Unterrichtseinheiten könnte man dann Raum dafür geben, aktuelle Spielbeobachtungen aus der Praxis zu reflektieren. Meiner Erfahrung nach wird diese Möglichkeit gern genutzt.

Für den Leistungsnachweis führen die Fachschüler und Fachschülerinnen dann eine strukturierte Spielbeobachtung durch. Dies kann mit scenotestähnlichem Material oder mit anderem Rollenspielmaterial erfolgen.

In der Auswertung ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass dieses Material selbstverständlich auch für einzelne Fördereinheiten gut eingesetzt werden kann. Es eignet sich besonders zur Darstellung des inneren Erlebens von (ggf. auch traumatisierten) Kindern (Erkennen der Symbolfunktion von Spiel), kann in diesem Zusammenhang auch bei gehörlosen oder nichtsprechenden Kindern bzw. nicht Deutsch sprechenden Kindern Hinweise zu deren Weltverständnis liefern.

Hierbei versteht sich die von der Diagnostik ausgehende heilpädagogische Spielbegleitung als ein ganzheitliches Vorgehen, das sich selbstverständlich nicht an isolierten Störungen/Auffälligkeiten eines Kindes orientiert, sondern der Stabilisierung, Entlastung und Unterstützung sowohl des Kindes als auch dessen Umfeldes dient.

(Quelle Schroer, Barbara: Heilpädagogische Entwicklungsförderung und Begleitung im Spiel, In: heilpaedagogik.de, Heft 4 / 2015 S.6 ff)

Sybille Lenk

## **Modul 13: „Heilpädagogische Spielbegleitung“ Teil II**

Zu der in diesem Modul zu erwerbenden Fachkompetenz gehört es, im Rahmen der heilpädagogischen Diagnostik auch spieldiagnostische Kompetenzen zu erwerben.

Um diese fachlich abgesichert erheben zu können, müssen die Fachschüler und Fachschülerinnen unterschiedliche Zugänge kennenlernen.

Dabei werden sie mit Beobachtungsbögen zum Stand der Spielentwicklung vertraut gemacht.

Hier kommt man bei fachgerechter Anwendung der Bögen zu gut abgesicherten Aussagen.

Deutlich komplizierter ist es, Aussagen zum szenischen Fallverstehen vor allem von Rollenspielsequenzen zu treffen.

Hier bietet die Anwendung projektiver Verfahren wie zum Beispiel der Scenotest nach Gerhild von Staabs eine anerkannte Grundlage der diagnostischen Erhebung.

Da im Regelfall in den Einrichtungen ein solcher Test nicht vorhanden ist, werden die Fachschüler ermutigt, ihre Spielbeobachtung mit scenotestähnlichen Materialien, welche aus den vorhandenen Spielgegenständen zusammengestellt werden können, durchzuführen. Dabei tragen die Beobachtungen in der Regel zum Fallverstehen – gerade bei Kindern mit traumatischen Lebensgeschichten – bei.

Auch hier werden die Fachschüler und Fachschülerinnen darauf hingewiesen, dass mit den Beobachtungsergebnissen verantwortungsbewusst umzugehen ist, diese immer nur Hinweise jedoch nie Beweise liefern.

Das ist besonders im Zusammenhang mit Hinweisen auf sexuellen Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung zu beachten.

Die psychoanalytisch fundierte Interpretation von Beobachtungen bleibt entsprechend ausgebildeten Fachärzten vorbehalten.

In den Lehrveranstaltungen bietet sich aber Raum zur Darstellung von in der Praxis beobachteten Spielszenen und deren Reflexion in der Ausbildungsgruppe.

Dabei erhält der Fachschüler/die Fachschülerin die Möglichkeit, eigene Beobachtungen abzusichern, diese einzuordnen und Ansätze für die weitere Förderarbeit zu entwickeln. Dieser Prozess wird in der Regel als sehr fruchtbar und hilfreich für die konkrete Arbeit in der Praxis gesehen.

Dabei sollte man immer wieder auf die theoretischen Grundlagen zum Spiel als Hauptausdrucksmöglichkeit für Inneres Erleben verweisen. Damit bietet das Spiel auch einen wesentlichen Ansatz für Kinder, Selbstheilungskräfte zu entwickeln, Hemmungen zu überwinden und so zu mehr Resilienz zu gelangen.

In diesem Zusammenhang sei auf Hans Zullingers 1951 erschienenes Grundlagenwerk „Heilende Kräfte im kindlichen Spiel“ verwiesen. Auf diese Quelle berufen sich alle modernen Autoren, welche das Verständnis kindlicher Spielprozesse für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in ihren Werken beleuchten.

Das szenische Darstellen von Lebenszusammenhängen und Entwicklungserschwernissen im Spiel müssen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in ihrer Symbolik deuten, aufgreifen und in der Spielförderung kreativ bearbeiten können.

Sybille Lenk

## **Modul 15: „Motorische Entwicklungsförderung (MEF)“**

In der MEF sollen angehende Heilpädagogen die Kompetenz erlangen, eine spezielle Förderung im motorischen Bereich eigenverantwortlich zu planen, durchzuführen und kritisch zu reflektieren. Die Fachschüler erfahren und erarbeiten sich, vor allem durch praktische Selbsterprobung, ein integriertes Wissen über spezielle Angebote und Übungen zur ganzheitlichen Förderung von Menschen mit und ohne Entwicklungsbesonderheiten in der visuellen, auditiven, vestibulären, taktilen und propriozeptiven Wahrnehmung, im Bereich komplexer Bewegungsabläufe sowie in der Feinmotorik. Das in den Modulen 1 bis 11 erworbene theoretische Wissen wird in der MEF praktisch unterlegt, erprobt und angewendet.

Im folgendem wird diese Einheit von Theorie und Praxis an zwei Beispielen - der Neurophysiologischen Entwicklungsförderung und der Diagnostik - beschrieben.

Im Kontext erhalten die angehenden Heilpädagogen in den Modulen 2, 4 und 6 (Medizinische Grundlagen heilpädagogischen Handelns, Grundlagen der heilpädagogischen Förderdiagnostik bei Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten und Menschen mit Beeinträchtigungen in der körperlichen und motorischen Entwicklung inklusiv erziehen, fördern und begleiten) einen Überblick über körperliche und motorische Entwicklungsbeeinträchtigungen.

### **1. Neurologische Entwicklungsförderung**

Ursachen von Entwicklungsauffälligkeiten können u. a. typische Auswirkungen von Restreaktionen frühkindlicher Reflexe sein. Diese sollten mit Fortschreiten der Hirnreifung abgebaut bzw. integriert und in Bewegungsmustern automatisiert sein. Die Fachschüler bekommen zunächst in den Modulen 2 und 4 einen theoretischen Einblick über Entstehung, Wirkungsweise und Abbau bzw. Integration einzelner Reflexe, wie z.B. über den Moro-, Palmar- und Plantar Reflex, der Asymmetrisch-Tonische und Symmetrisch-Tonische-Nackenreflex (ATNR, STNR) und der Tonische Labyrinth Reflex (TLR).

In der MEF werden nun Übungsmöglichkeiten zu einer gezielten Förderung in den einzelnen Entwicklungsbereichen praktisch aufgezeigt und selbst erprobt.

Als Einstieg eignet sich ein kleiner Test besonders gut. Die Fachschüler sollen mit geschlossenen Augen im Einbeinstand stehen und gleichzeitig komplizierte Rechen- bzw. Denkaufgaben lösen. In einer anschließenden gemeinsamen Reflexion erkennen die Schüler die Schwierigkeit, sich sowohl auf die Gleichgewichtserhaltung als auch auf die Rechenaufgaben zu konzentrieren. Ein sicherer, bereits geübter und automatisierter Stand könnte eine schnelle und richtige Lösung der Aufgaben bringen. An dieser Stelle sei noch einmal auf den Zusammenhang von Gleichgewicht, Haltung, Reflexen und Schulerfolg hingewiesen. Neurologische Dysfunktionen können zu Lernproblemen führen.

Im Anschluss daran bearbeiten wir jeden einzelnen Reflex – zunächst durch kurze gemeinsame Wiederholung ihrer Wirkungsweise und danach durch das Aufzeigen von Möglichkeiten einer gezielten Förderung mittels geeigneter Übungen.

So kann beispielsweise zur besseren Integration des Plantar Reflexes (Fußgreifreflex) eine Bewegungsgeschichte zur Schulung der Fußgeschicklichkeit mit den Schülern erarbeitet und erprobt werden.

### **2. Diagnostik**

Im Modul 4 erhalten die angehenden Heilpädagogen einen Einblick in verschiedene Überprüfungsverfahren, so auch in den Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder. Dieser Test dient als wichtiges Entscheidungskriterium zur Einleitung psychomotorischer Fördermaßnahmen. Es ist ein motometrisches Verfahren, der nicht nur Aufschluss über

## Didaktisch-methodische Handreichungen zu den Modulen

Entwicklungsauffälligkeiten und etwaige Verhaltensprobleme sondern auch über psychische Befindlichkeiten gibt.

In der MEF werden die einzelnen Testbereiche differenziert angeschaut und in entsprechende Erfassungsbereiche unterteilt. Im Anschluss daran werden für die einzelnen Bereiche spezielle Förderangebote erarbeitet und erprobt.

Praktisch und im Selbstversuch haben die Fachschüler in einem interessanten und abwechslungsreichen Unterricht erfahren, wie motorische Entwicklungsverzögerungen geschult und gefördert werden können.

Petra Tusch, BBZ Weimar

**Modul 17: „Heilpädagogisches Handeln in den Arbeitsfeldern“**

**17.1 „Heilpädagogen in Diensten und Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung“**

Die Kinder- und Jugendhilfe ist geprägt von einer kontinuierlichen Anpassung und Differenzierung der Angebote an die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Träger und Anbieter von Leistungen stehen unter hohem Legitimations- und Kostendruck.

Die Anpassungsbemühungen finden in der Qualitätsdiskussion, in Fragen der Organisation und den immer engere Grenzen ziehenden Leistungs- und Entgeltvereinbarungen ihren Niederschlag. Dieser Tatsache ist bei der Behandlung des Stoffes im Modul durchgehend Rechnung zu tragen, um hier einen hohen Theorie – Praxis – Bezug zu gewährleisten. Wenn Studierende aus dem Arbeitsfeld der Hilfen zur Erziehung in der Klasse sind, würde ich den Zugang so gestalten, dass diese Studierenden ihre Erfahrungen im Sinne eines Problemaufrisses reflektieren. Dabei wären solche Fragestellungen wie: Welche Gründe führten mich in dieses Arbeitsfeld? Welche Perspektiven sehe ich hier für mich? Wie sieht ein Arbeitstag/eine Arbeitswoche für mich aus? Was ist für mich Erfolg? Wo stoße ich an Grenzen? usw. möglich.

Sollte es niemanden mit Berufserfahrung geben, empfiehlt sich ein historischer Zugang über Strömungen oder bedeutende Persönlichkeiten (Pestalozzi, Falk, Wiechern, Rettungshausbewegung) als Quellen. Auch zur Geschichte der Heimerziehung der 50iger und 60iger Jahre gibt es eindrucksvolle Dokumente.

Biografisch unterlegte belletristische Werke bieten sich ebenfalls an und erlauben emotionale Zugänge zur Thematik.

Erst danach würde ich die doch oft sehr sperrig formulierten rechtlichen Grundlagen des SGB VIII behandeln.

Denkbar ist hier auch, immer sofort den Zusammenhang der rechtlichen Grundlagen zu den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe herzustellen und somit die Paragraphen mit Leben zu füllen.

Kinder und Jugendliche fordern in ihrer Lebenswelt die sie betreuenden Erwachsenen oft durch extremes, sich und andere gefährdendes Verhalten heraus. Im Kurs sollte Raum für die ehrliche Reflektion und die Thematisierung dieser Probleme z. B. im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdung, Trauma, Flucht unbegleiteter Minderjähriger und Migration sein.

Auch zu traumapädagogischen Standards in der Jugendhilfe, zu kultursensiblen Handeln und genderspezifischen Zugängen gibt es sehr gute Literatur und Materialien.

Diese können z.B. bei der Behandlung der Leistungsbeschreibung/Konzeptentwicklung oder der interdisziplinären Hilfeplanung einbezogen werden.

Systemische Zusammenhänge lassen sich gut in Bezug auf den Kontakt/bzw. nicht möglichen direkten Kontakt mit leiblichen Eltern, Adoptiv- und Pflegeeltern oder Großeltern verdeutlichen. Auch hier geht es um das Entwickeln einer akzeptierenden, wertschätzenden Haltung des Heilpädagogen/der Heilpädagogin als Anwalt von in ihrer Entwicklung gefährdeten Kindern und Jugendlichen.

Im Kurs können vielfältige Anregungen zur Arbeit mit problemorientierter Kinder- und Jugendliteratur (z. B. für Pflege- und Adoptivkinder, Kinder psychisch kranker und suchtkranker Eltern, Texte von Heimkindern, Filme) gegeben werden, welche die Identifikation mit literarischen Figuren ermöglichen und Kinder in ihrer Identitätsentwicklung unterstützen.

Quelle: Berufsverband der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen Fachverband für Heilpädagogik (BHP) e.V. (Hrsg.): Positionspapier Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Jugendhilfe

Michaelkirchstraße 17/18  
10179 Berlin

Sybille Lenk



**Modul 17: „Heilpädagogisches Handeln in den Arbeitsfeldern“**  
**17.2 „Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und drohenden Behinderungen“**

Da der Begriff der „Behindertenhilfe“ genauso ambivalent und auch vielschichtig wie der der Behinderung ist, empfiehlt sich auch hier ein historischer Ansatz.

So kann der Umgang mit Menschen mit Behinderung von der Antike bis zur Gegenwart z. B. in Vorträgen überblicksartig beleuchtet werden.

Die historischen Entwicklungslinien beziehen entsprechende Veränderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen mit ein und verdeutlichen den Paradigmenwechsel vom eher paternalistisch geprägten Betreuer zum Begleiter des Menschen mit Behinderung.

In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Professionalisierung des Berufes des Heilpädagogen/der Heilpädagogin behandeln. Dies kann z. B. mit Hilfe historischer Anstaltsordnungen, Chroniken, Festschriften von Einrichtungen oder anhand von Dissertationen zur Geschichte der Hilfe für Menschen mit Behinderungen geschehen.

Sehr wertvoll und zur Thematik hinführend ist auch der Zugang über die narrative Heilpädagogik ([www.erzaehltebehinderung.ch](http://www.erzaehltebehinderung.ch)). Hier geht es darum, literarische Texte als Erzählungen über Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen in sozialen Zusammenhängen für die Heilpädagogik als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und Erkenntnis zu erfassen und zu erschließen.

Die Handlungsfelder und die Rolle von Heilpädagogen sind gut im Positionspapier „Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung“ (Hrsg. Berufs- und Fachverband Heilpädagogik e.V., Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin) beschrieben.

Unterschiedliche Leitbilder, Konzepte verschiedener Träger, aktuelle Therapie- und Behandlungspläne sowie Leistungsbeschreibungen und Handbücher zur Qualitätssicherung können im Unterricht vorgestellt, verglichen und diskutiert werden.

Dabei sollten die Aspekte der möglichst weitest gehenden Selbstbestimmung des Menschen mit Behinderung, seiner Inklusion im Sozialraum und seiner Teilhabemöglichkeiten (vgl. Bundesteilhabegesetz) am Leben der Gesellschaft besondere Beachtung finden.

Davon ausgehend werden entsprechende Aufgaben für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen als Anwalt des Menschen mit Behinderung abgeleitet.

Als Leistungsnachweis wäre die Entwicklung eines Kursangebotes oder eines Konzeptes für Kurse in der Erwachsenenbildung denkbar. Das kann auch in Gruppen erfolgen.

Als besondere Herausforderung wird in der Praxis oft die Kooperation mit Angehörigen, gesetzlichen Betreuern sowie Konfliktlösung in systemischen Zusammenhängen empfunden.

Hier ist es günstig, Regeln der Gesprächsführung und der gewaltfreien Kommunikation zu vertiefen und ggf. in quasi – real – Situationen zu üben.

Wenn Teilnehmer hier Fallbeispiele aus der Praxis einbringen, sind diese in jedem Fall vertraulich zu behandeln. Die Lehrerin/der Lehrer sollte unbedingt darauf achten, alle Teilnehmer über ihre Schweigepflicht zu belehren und dies auch aktenkundig machen.

Hier ist die Unterstützung im Sinne kollegialer Fallberatung möglich, da schwer zu deutendes, problematisches und herausforderndes Verhalten von Menschen mit Behinderungen in der Praxis Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft sehr belastet.

Sybille Lenk

## **Modul 18: „Heilpädagogische Förderpraxis – Berufspraktikum – Anfertigen einer Facharbeit“**

Die Anfertigung der Facharbeit am Ende des Berufspraktikums stellt erfahrungsgemäß für die Fachschülerinnen und Fachschüler eine große Herausforderung dar.

Sie bedarf in der Regel einer guten Anleitung, der Prozessbegleitung und regelmäßigen Rückmeldung.

Die das Berufspraktikum begleitenden Kolleginnen und Kollegen bewerten sowohl die Leistungen im Berufspraktikum als auch die Facharbeit sowie gemeinsam mit einem zweiten Fachlehrer das Kolloquium.

So entwickelt sich in dieser Zeit noch einmal eine enge Arbeitsbeziehung zwischen Fachschüler/Fachschülerin und Mentor/Mentorin der Ausbildungsstätte.

Das bedeutet für die Lehrerin/den Lehrer möglichst zeitnah auf Anfragen von Fachschülerinnen und Fachschülern zu reagieren und eine differenzierte Reflexion des Prozesses zu ermöglichen.

Jede Fachschule hat ihre eigenen Hinweise zur Erstellung von Facharbeiten, auf die sich die Fachschülerinnen und Fachschüler beziehen müssen. Hier sind Formalia geregelt und es werden allgemeine Hinweise zum Gliedern, Zitieren usw. gegeben.

Die Seitenzahlen für Heilpädagogen weichen in der Regel von den für die Facharbeiten von Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen festgelegten erheblich ab.

Dies ergibt sich allein aus der umfangreichen Anamnese und Beschreibung des Klienten/der Klientin, der Überprüfung und Auswertung der Entwicklungsstände zu Beginn und zum Ende des Praktikums sowie der gründlichen Prozessreflexion.

Da in der Facharbeit der gesamte Prozess der heilpädagogischen Diagnostik, der Planung, Durchführung und Reflexion der heilpädagogischen Fördereinheiten dokumentiert werden soll, bedarf die Arbeit einer sorgfältigen Struktur, um hier ein angemessenes Verhältnis zwischen theoretischen Ausführungen und Praxisteil zu erreichen. Themenformulierung, Zielstellung und Gliederung sollten individuell mit den Fachschülerinnen und Fachschülern besprochen werden.

Das Spezifische einer heilpädagogischen Abschlussarbeit sollte sich hier widerspiegeln.

Ein wichtiger Punkt ist auch die Eingrenzung des theoretischen Teils der Arbeit.

In der Zielstellung muss neben dem Aufbau der Arbeit, den Motiven der Themenwahl, dem methodischen Vorgehen auch die Abgrenzung begründet werden. Hinweise zur Einhaltung der Normen der Redlichkeit des wissenschaftlichen Arbeitens sowie des Datenschutzes sollten in jedem Fall, sofern das noch nicht erfolgt ist, als Belehrung im Klassenbuch vermerkt werden.

Es gibt sehr viele Veröffentlichungen zur Anfertigung von wissenschaftlichen Arbeiten.

Wir erlauben uns, auf eine vom Förderverein des Internationalen Archivs für Heilpädagogik e.V. herausgegebene Veröffentlichung gesondert hinzuweisen.

Klein Ferdinand: Handreichung für das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten im Studien- und Forschungsfeld der Heilpädagogik, Wissenschaftliche Reihe/Band 1, Berlin 2016

Sybille Lenk

## **Modul 18: „Heilpädagogische Förderpraxis – Berufspraktikum“**

Mit diesem Modul begeben sich die Fachschüler in die heilpädagogische Förderpraxis und erhalten die Möglichkeit erworbene Kenntnisse, fundiertes Wissen sowie fachpraktische Fertigkeiten hinsichtlich einer heilpädagogischen Förderdiagnostik, des Aufstellens von Förderzielen in Form eines Förderplanes, heilpädagogischer Methoden und Handlungsansätze, deren Gestaltung und Reflexion im heilpädagogischen Förderprozess anzuwenden. Den Pädagogen der Fachschule stehen in diesem Prozess für die Begleitung und Unterstützung der Fachschüler 320 Unterrichtsstunden im dritten Ausbildungsjahr zur Verfügung. Wichtige Aspekte werden zur Planung, Durchführung und Reflexion von heilpädagogischen Fördereinheiten (HPFE) im Berufspraktikum sowie zur Dokumentation des gesamten Förderprozesses in einer Praktikums-mappe wie auch zur Erarbeitung der Facharbeit zum Abschluss berücksichtigt.

Bedeutsam ist eine umfassende Einweisung der Fachschüler vor Beginn des Berufspraktikums und eine individuelle Anleitung in der heilpädagogischen Förderpraxis. Eine Orientierung für ihr eigenverantwortliches Handeln erfahren die Fachschüler durch eine zeitliche Strukturierung in einer Einweisung durch den Fachlehrer zum Ablauf der Praktikumszeit, welche die Planung und Umsetzung klar definiert.

Mögliche Anhaltspunkte können sein:

- **Beginn des Berufspraktikums:** Woche vom ... (TTMJ) bis ... (TTMJ) / Eintragung in eine **Praktikumsvereinbarung** (Ausgabe der Vereinbarung durch Fachlehrer PraxM 18 am ... Datum – Vereinbarung bis ... Datum unterschrieben zurück von Fachschülern / Einrichtung an **Fachlehrer PraxM 18** – Original mit Unterschrift von Schulleiter zurück an Fachschüler)
  - **bei fehlender Praktikumsvereinbarung** kein Beginn des Praktikums/Beachten der notwendigen Unterschriften/1 Kopie zum Verbleib an Fachschule (Versicherungsschutz)
  - ca. 44 Wochen, abzüglich etwa 5 Wochen Urlaub Praktikant/Klient - ca. **40 HPFE** – d.h. Praktikum durchgängig unabhängig von eventuellen Schulferien
- **Heilpädagogische Diagnostik** – bis spätestens ... (Datum – ca. 6 Wochen nach Praktikumsbeginn)

soweit inhaltlich zusammengetragen, dass Auskünfte zur Anamnese und Beschreibung, zu Ressourcen, Interessen, Auffälligkeiten und Förderansätzen dem betreuenden Fachlehrer bei **1. Hospitation** erteilt werden können
- Terminabsprachen mit betreuendem Fachlehrer aus Fachschule (Datum im naheliegenden Zeitrahmen) zum **ersten Praktikumsbesuch** ab ... (Datum)
- während Erstellung der Diagnostik (HPFD) schon erste Förderung mit Klient
- Überprüfungsverfahren und Tests als Teile der Förderung / im Angebot mit einbauen
- **Wichtig (auch) für die Facharbeit** - bis ... (Datum, ca. 8 bis 9 Wochen nach Beginn Praktikum) sollten komplette heilpädagogische Diagnostik (Anamnese bis Förderschwerpunkte) sowie Facharbeits-Thema und Grobgliederung stehen

Bedeutsam für die Fachschüler ist in diesem Ausbildungszeitraum auch die Frage nach der **Benotung**, welche mit in die zeitliche Planung eingearbeitet werden kann.

- **2 inhaltlich / thematisch aufeinander aufbauende HPFE** (können auch z. B. HPFE 15 und 18 sein) werden zur Benotung und als Vorleistung erbracht – Abgabetermin ... (*Datum*) beim Fachlehrer KM 4 – **2 Noten KM 4**
- **Zweite Hospitation** im Praktikum ab ... (Zeitraumen um 8./9. Monat im Förderprozess) – Absprache mit betreuendem Fachlehrer der Fachschule und Mentor der Einrichtung – **1 Note PraxM 18 (Leistungsfeststellung)**: setzt sich zusammen aus 3 Teilnoten: schriftliche Planung/Durchführung/Reflexion)
  - schriftliche Planung für 2. Hospitation **1 Woche** (5 Werktage) vor der Durchführung bei betreuendem Fachlehrer und Mentor in diesem Zeitraum (8./9. Monat in Förderpraxis) abgeben
  - die **Dokumentation in Form einer/s Praktikumsmappe/ordners** an betreuenden Fachlehrer zur Einsicht und Bewertung abgeben (8./9. Monat in Förderpraxis) – wichtig (auch der Rücklauf durch den betreuenden Fachlehrer an den Fachschüler) für Facharbeit (da diese Dokumentation für Gliederungspunkte u. a. zur „Reflexion im heilpädagogischen Förderprozess“ und „Vergleich des Entwicklungsstandes ...“ benötigt wird) – **1 Note in PraxM 18 (Vorleistungen)**
- heilpädagogische Förderung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet (zweite Überprüfung Test oder Überprüfungsverfahren im Vergleich zur ersten Überprüfung mit Blick auf aktuellen Entwicklungsstand u. a.) – Abschluss der intensiven Förderung vorbereiten und Perspektiven für Klienten betrachten

Zur Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der Aktivitäten und Ergebnisse ihrer Arbeit in der heilpädagogischen Förderpraxis legen die Fachschüler eine **Mappe bzw. einen Ordner** an, der inhaltlich folgendermaßen strukturiert sein kann:

1. Praktikumsvereinbarung mit Fördereinrichtung im Original (mit Unterschriften)
2. Terminübersichten/Ergänzungen/Absprachen mit dem betreuenden Fachlehrer/ggf. Mentor der Fördereinrichtung
3. Praxis-/Fördereinrichtung - Konzeption
4. Gruppenstruktur, in der sich Klient befindet – kurz erläutern (besondere Verhältnisse, Beziehung zu Gruppenmitgliedern, Erziehern oder Heilpädagogen, Eingliederungsbedingungen ...)
5. 4 Beobachtungsprotokolle zu Aktivitäten vom Klienten in verschiedenen Situationen unter unterschiedlichen Beobachtungsschwerpunkten wie Motorik/ Sozialverhalten/Sprache... (vgl. Materialien zu Beobachtungsprotokollen – auch Protokolle vom Elterngespräch/Elternbesuch, von Gesprächen mit Erziehern/Betreuern)
6. Anamnese des Klienten
7. Beschreibung des Klienten
8. Überprüfungsverfahren und verbale Auswertung hierzu zu Beginn der Förderung und am Ende des Förderprozesses
9. Förderschwerpunkte auf der Grundlage der heilpädagogischen Diagnostik/ Förderplan
10. Heilpädagogische Fördereinheiten (HPFE) fortlaufend (1 bis 40)

Die Fachschüler bündeln ihre Erfahrungen und Ergebnisse aus ihrem Berufspraktikum und binden diese thematisch in ihre **Facharbeit** ein. Dieses basiert auf der Grundlage

## Didaktisch-methodische Handreichungen zu den Modulen

wissenschaftlichen Arbeitens sowie einer Dokumentation und Reflexion zum eigenen heilpädagogischen Handeln.

Diese Handreichung soll als Anregung verstanden werden und ist nicht bindend hinsichtlich der Planung und Umsetzung der Inhalte im Lehrplan Heilpädagogik durch die jeweiligen Fachschulen.

Antje Schmalisch